

PELUANG RISET BEREAVEMENT CARE DI INDONESIA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MENTAL KELUARGA YANG BERDUKA

Christina Yeni Kustanti
Ninik Yunitri



PELUANG RISET *BEREAVEMENT CARE* DI INDONESIA: UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MENTAL KELUARGA YANG BERDUKA

Penulis:

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Pall.C., Ph.D.

Ninik Yunitri, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J., Ph.D.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Peluang *Riset Bereavement Care* Di Indonesia: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mental Keluarga Yang Berduka

Penulis: Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Pall.C., Ph.D.
Ninik Yunitri, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J., Ph.D.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7139-01-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Palliative Care mulai berkembang di Indonesia sejak 1992 dan *Bereavement Care* atau dukungan proses berduka merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *Palliative Care*. Penulis mendalami bidang *Palliative Care* sejak 2012 dan berfokus pada area *Bereavement Care* sejak 2018. Tujuan utama *Bereavement Care* adalah pendampingan keluarga atau *caregiver* yang berduka karena kehilangan anggota keluarga dalam melalui masa berdukanya tanpa mengalami komplikasi menuju ke tahap penerimaan (*acceptance*).

Penulis telah melakukan berbagai penelitian dan review yang berhubungan dengan *Bereavement Care* pada tahap yang lebih umum atau di tingkat global. Buku monograf ini disusun sebagai tahap awal perencanaan penelitian di area *Bereavement Care* di Indonesia. Buku ini dapat menjadi panduan para peneliti, khususnya di Indonesia, peluang riset yang dapat direncanakan untuk area *Bereavement Care*. Penelitian di area ini sangat penting untuk kontinuitas perawatan di tingkat keluarga, bahwa seharusnya perhatian pada keluarga yang sakit tidak hanya berhenti ketika pasien meninggal, tetapi keluarga yang ditinggalkan juga perlu mendapatkan perhatian.

Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

BAB 2 EPIDEMIOLOGI.....7

- A. Prevalensi *grief disorder* secara umum 7
- B. Prevalensi *grief disorder* karena kanker 8
- C. Prevalensi *grief disorder* karena kematian yang tidak diantisipasi 9
- D. Prevalensi *grief disorder* di masa pandemic COVID-19..... 10
- E. Prevalensi *grief disorder* untuk area *pre-loss* (sebelum kematian) 11

BAB 3 SKRINING PROSES BERDUKA..... 13

- A. Instrumen untuk Proses Berduka..... 13
- B. Skrining Berduka Antisipasi..... 13
- C. Instrumen Berduka 15
- D. Instrumen Berduka Terkomplikasi 16

BAB 4 DIAGNOSIS & INTERVENSI PROSES BERDUKA..... 19

- A. Jenis Berduka 19
- B. Diagnosa Prolonged Grief Disorder 21
- C. Diagnosa Keperawatan Respon Berduka 27

D. Intervensi respon berduka.....	32
BAB 5 KOMPLIKASI GANGGUAN BERDUKA	43
BAB 6 BUKTI ILMIAH TENTANG <i>GRIEF</i> DAN <i>BEREAVEMENT</i>	49
A. Penelusuran Literatur.....	49
B. Hasil Penelusuran Literatur.....	52
BAB 7 PELUANG PENELITIAN <i>GRIEF</i> DAN <i>BEREAVEMENT</i>	67
BAB 8 PENUTUP.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
GLOSARIUM	81
PROFIL PENULIS	85

BAB 1

PENDAHULUAN

Palliative care atau perawatan paliatif merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan orang yang hidup dengan *life-threatening illness* atau penyakit yang mengancam jiwa. Penyakit yang mengancam jiwa ini umumnya adalah penyakit-penyakit kronis atau *advance*. Tujuan utama dari perawatan paliatif berdasarkan *World Health Organization* (WHO) adalah *“an approach that improves the quality of life of patients (adults and children) and their families who are facing problems associated with life-threatening illness”* (WHO, 2020). Inti dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perawatan paliatif merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien; baik anak-anak maupun dewasa, termasuk keluarganya, yang mengalami penyakit serius. Pengertian tersebut juga menegaskan bahwa fokus perawatan tidak hanya pada pasien, tetapi juga keluarganya.

Saat pasien dirawat di rumah sakit atau di rumah, fokus perhatian tenaga kesehatan dan seluruh keluarga adalah pada pasien. Dengan budaya dan *bonding* (keeratn hubungan) di antara anggota keluarga, perawatan anggota keluarga yang sakit umumnya dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Pasien dengan penyakit kronis inilah yang akan mendapatkan perawatan paliatif, dengan porsi yang dinamis bersama perawatan kuratif. Sesuai perkembangan penyakit dan kondisi pasien, porsi antara kuratif dan paliatif akan menyesuaikan. Perawatan pasien dengan kasus-kasus seperti kanker, demensia, gagal ginjal, atau HIV AIDS misalnya,

sangatlah intensif dan umumnya mempengaruhi kehidupan pasien dan seluruh anggota keluarganya. Ketika pasien meninggal, intensitas perawatan pasien seolah-olah terhenti. Hubungan dengan pusat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas, juga seolah-olah terhenti. Padahal sebenarnya, keluarga juga akan memerlukan perhatian untuk kesejahteraan mentalnya paska meninggalnya pasien.

Perawatan paliatif mempunyai tiga domain utama perawatan, yaitu paliatif primer, perawatan akhir kehidupan (*end-of-life care*), dan perawatan masa berduka (*bereavement care*). Buku ini akan berfokus pada domain perawatan masa berduka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paska kehilangan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, proses alamiah yang akan dialami adalah reaksi berduka. Duka adalah respons terhadap berbagai kehilangan; individu merasakan kedukaan atas kehilangan orang yang mereka cintai, vitalitas, peluang, harta benda, dan kemampuan fungsional (Zisook et al., 2018). Duka adalah respon normal atau wajar, yang dialami oleh keluarga. Meskipun dinyatakan sebagai respons normal, duka adalah pengalaman unik bagi setiap individu dan setiap jenis kehilangan (Zisook et al., 2018). Kehilangan seseorang yang dekat, terutama anggota keluarga, adalah kehilangan besar dan bisa menjadi pengalaman yang paling menantang serta menyedihkan. Setiap kematian dapat memengaruhi sembilan orang yang memiliki hubungan erat (Verdery et al., 2020). Dalam kasus penyakit tidak menular (PTM), misalnya, PTM menyumbang 74% dari semua kematian di seluruh dunia, atau sekitar 41 juta kematian per tahun (WHO, 2022), yang menyebabkan 360 juta orang berduka. Selain penyakit tidak menular, jumlah individu yang berduka meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang Indonesia mengalami duka

cita akibat lebih dari 160.000 kematian selama pandemi COVID-19 (WHO, 2022).

Duka didominasi oleh perasaan sedih dan kesepian, yang dapat dialami beberapa saat setelah kehilangan. Tetapi perasaan ini akan menghilang seiring berjalannya waktu. Proses inilah yang umumnya dilalui oleh kebanyakan orang. Akan tetapi, sebagian kecil orang akan mengalami reaksi berduka yang cukup intens, yang tidak akan hilang meskipun peristiwa kehilangannya sudah berlangsung lama. Inilah yang kemudian disebut sebagai *complicated grief* atau *prolonged grief disorder*, yang merupakan reaksi berduka yang terkomplikasi.

Sepuluh dari 100 orang mengalami reaksi berduka yang terkomplikasi (Lundorff et al., 2017). Prevalensi ini akan berbeda-beda tergantung dari penyebab kehilangan. Pada keluarga yang kehilangan pasien dengan kasus kanker, disorder dapat dialami pada 14.2% (95% CI, 11.7%-16.7%). Tetapi untuk kehilangan karena kematian yang mendadak akibat kecelakaan, COVID-19, bencana alam, atau penyebab lain yang tidak diantisipasi, maka prevalensinya meningkat menjadi antara 45-49% (Djelantik et al., 2020; Kustanti et al., 2023). Bahkan reaksi berduka juga dapat dialami oleh keluarga sebelum pasien tersebut meninggal. Kejadian reaksi ini, atau disebut sebagai *anticipatory grief*, mencapai 24.78% (95% CI 19.04% to 30.99%) (C. Y. Kustanti et al., 2022). *Grief disorder* sendiri dapat didiagnosis dengan menggunakan *International Classification for Diseases* (ICD) Edisi 11 dengan istilah *Prolonged Grief Disorder*. Selain itu, dapat juga menggunakan the DSM-5 atau *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses* sebagai diagnosis *Persistent Complex Bereavement Disorder*.

Pengalaman berduka yang terkomplikasi dapat menimbulkan berbagai masalah lanjutan, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sebelum terdaftar sebagai suatu

diagnosis di ICD maupun DSM, masalah mental yang timbul pasca kehilangan umumnya didiagnosis dengan disorder yang lain, seperti depresi, kecemasan, atau *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dan ditangani dengan intervensi-intervensi untuk jenis-jenis disorder tersebut. Para ahli dan peneliti di area *bereavement care* seperti Prigerson, Neimeyer, dan Reitsma berusaha untuk menyediakan bukti ilmiah bahwa seharusnya berduka terkomplikasi terdaftar sebagai diagnosis tersendiri. Prigerson berusaha untuk mengembangkan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan skrining atau diagnosis dari *grief*, sebutan untuk reaksi berduka. Instrumen yang telah dibuat oleh Prigerson diantaranya adalah *Prolonged Grief Disorder – 13* (PG-13) dan *Inventory of Complicated Grief* (ICG) (Kustanti, Chu, et al., 2021; Prigerson et al., 2021; Prigerson et al., 1995; Sealey et al., 2015).

Kedukaan patologis meningkatkan risiko masalah psikologis yang lebih lanjut, seperti gangguan stres pasca-trauma dan depresi (Shear, 2012). Tingkat kortisol rata-rata yang lebih tinggi, kemiringan kortisol diurnal yang datar, dan kortisol pagi yang lebih tinggi telah teridentifikasi pada subjek yang berduka (Hopf et al., 2020). Sebagai akibat langsung dari ini, masalah psikologis juga dapat memengaruhi masalah fisik. Selain itu, kedukaan dapat menyebabkan peningkatan konsumsi tembakau dan alkohol, serta berperan dalam pengembangan morbiditas fisik baru dan bahkan bunuh diri (Pitman et al., 2020). Mengingat beban kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh gangguan kedukaan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan merawat individu yang berduka dengan menggunakan berbagai metode. Untuk memberikan perawatan yang tepat bagi individu yang berduka, akan sangat penting untuk mengumpulkan bukti, melalui penelitian, tentang perawatan berduka.

Berbagai jenis studi perawatan paliatif telah dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Rochmawati et al., 2016). Namun, masih ada kekurangan penelitian tentang perawatan berduka, dan juga kurangnya informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut kedukaan yang diberikan oleh layanan spesialis (Guldin, 2014). Faktanya, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kedukaan di Indonesia mengingat latar belakang budaya dan sumber daya masyarakatnya yang beragam. Orang yang berduka di Indonesia seharusnya memiliki akses ke perawatan berduka yang mempertimbangkan kebutuhan individu mereka. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk membahas studi proses berduka di Indonesia. Pemetaan penelitian *bereavement care* di Indonesia akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

BAB 2

EPIDEMIOLOGI

A. Prevalensi *grief disorder* secara umum

Gangguan proses berduka yang berkepanjangan (atau *prolonged grief disorder*– PGD) adalah sindrom khusus berduka yang dimasukkan dalam ICD-11. Menentukan prevalensi PGD akan memiliki implikasi penting dalam hal klinis dan terapeutik. Tinjauan sistematis dan meta-analisis dari Lundorff et al. (2017) bertujuan untuk memperkirakan tingkat prevalensi PGD pada populasi dewasa yang berduka, mengidentifikasi moderator yang mungkin ada, dan mengeksplorasi kualitas metodologis dari penelitian di bidang ini. Pencarian literatur sistematis dilakukan di PubMed, PsycINFO, Embase, Web of Science, dan CINAHL. Studi dengan populasi dewasa non-psikiatrik yang terpapar pada berduka non-violent (seperti kematian karena pembunuhan, kecelakaan, atau bencana alam) dimasukkan dan dievaluasi secara meta-analitik. Empat belas studi yang memenuhi syarat diidentifikasi. Meta-analisis mengungkapkan prevalensi gabungan PGD sebesar 9.8% (95% CI 6.8–14.0). Analisis moderasi menunjukkan bahwa usia rata-rata yang lebih tinggi terkait dengan prevalensi PGD yang lebih tinggi.

Studi yang memenuhi syarat sesuai kriteria inklusi memiliki metodologi yang heterogen. Beberapa keterbatasan termasuk hanya sebagian dari studi yang menggunakan metode pengambilan sampel probabilitas berbasis registri (50.0%) dan sedikit studi yang menganalisis non-responden (14.3%). Studi ini merupakan tinjauan

sistematis dan meta-analisis pertama tentang prevalensi PGD dan menunjukkan bahwa satu dari sepuluh orang dewasa yang berduka berisiko mengalami PGD. Untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dan profesional secara lebih efektif, studi menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi dan menawarkan perawatan kepada individu yang berduka yang paling membutuhkan. Mengingat heterogenitas dan keterbatasan representativitas, temuan ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan diperlukan penelitian epidemiologi berkualitas tinggi tambahan yang menggunakan desain berbasis populasi.

B. Prevalensi *grief disorder* karena kanker

Perawatan kanker adalah pengalaman yang penuh tekanan, dan kehilangan orang yang tercinta dapat menyebabkan kedukaan yang mendalam serta dampak negatif lainnya. Namun, prevalensi gangguan proses berduka di kalangan keluarga yang berhubungan dengan kematian akibat kanker masih belum diketahui. Penelitian dari Kustanti et al. (2022) bertujuan untuk menentukan prevalensi gangguan proses berduka di antara keluarga pasien kanker untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada para klinisi, peneliti, dan pembuat kebijakan. Database CINAHL, Embase, MEDLINE, PubMed, Scopus, PsycINFO, dan Web of Science telah dicari secara komprehensif tanpa batasan bahasa. Kualitas studi yang memenuhi kriteria dinilai dengan kriteria Hoy.

Dari 3,046 artikel yang disaring, 19 studi memenuhi syarat untuk meta-analisis, dengan total 14,971 partisipan. Prevalensi gabungan proses berduka terkomplikasi diperkirakan sebesar 14.2% (95% CI, 11.7%–16.7%), dengan kisaran antara 7% hingga 39%. Prevalensi lebih tinggi pada perempuan (10%; 95% CI, 8.2%–12.1%), individu yang

religius (9.55%; 95% CI, 8.97%–10.16%), pasangan almarhum (7.78%; 95% CI, 6.08%–9.69%), dan keluarga pasien dengan kanker neurologis (6.4%; 95% CI, 0.10%–19.9%). Tingkat pendidikan, lokasi studi, alat diagnosis, waktu setelah kehilangan, dan metode studi tampaknya tidak memengaruhi prevalensi gangguan kedukaan pada keluarga pasien kanker.

Karena prevalensi gangguan kedukaan pada berduka akibat kanker cukup besar, dukungan termasuk perawatan paliatif sangat penting untuk mengurangi beban perawatan. Selain itu, penelitian di masa depan diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi strategi efektif yang dapat membantu mengurangi beban yang disebabkan oleh gangguan kedukaan setelah kematian pasien.

C. Prevalensi *grief disorder* karena kematian yang tidak diantisipasi

Penelitian sebelumnya oleh Lundorff et al. (2017) menunjukkan bahwa satu dari sepuluh individu yang berduka secara alami mengembangkan gangguan proses berduka yang berkepanjangan (PGD). Namun, lebih sedikit yang diketahui mengenai prevalensi PGD setelah kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan, bencana, bunuh diri, atau pembunuhan. Tujuan dari penelitian Djelantik et al. (2020) adalah untuk menghitung prevalensi gabungan PGD dan menentukan kemungkinan penyebab perbedaan estimasinya. Pencarian literatur dilakukan di PsycINFO, Ovid Medline, PILOTS, Embase, Web of Science, dan CINAHL. Meta-analisis menggunakan model efek acak dilakukan untuk menghitung prevalensi gabungan PGD. Meta-regresi multivariat digunakan untuk mengeksplorasi heterogenitas antar studi.

Sebanyak 25 artikel memenuhi kriteria kelayakan. Prevalensi gabungan dengan *random-effects* adalah 49%, 95% CI [33,6, 65,4]. Kematian anak tunggal, pembunuhan kekerasan, dan lokasi studi non negara-negara Barat terkait dengan prevalensi PGD yang lebih tinggi. Waktu yang lebih lama setelah kehilangan dan kehilangan akibat bencana alam terkait dengan prevalensi PGD yang lebih rendah. Temuan ini harus ditafsirkan dengan hati-hati, mengingat adanya heterogenitas dalam metodologi studi. Meta-analisis ini adalah studi pertama tentang PGD setelah kehilangan yang tidak wajar dan menunjukkan bahwa hampir setengah dari orang dewasa yang berduka mengalami PGD. Hal ini menggambarkan pentingnya penilaian PGD pada individu yang terpengaruh oleh kehilangan dan trauma.

D. Prevalensi *grief disorder* di masa pandemic COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak kematian dan jutaan orang di seluruh dunia berduka atas kehilangan orang yang mereka cintai, yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prevalensi gejala dan gangguan berduka di antara individu yang berduka akibat kematian terkait pandemi, untuk mengembangkan kebijakan, praktik, dan prioritas penelitian (Kustanti et al., 2023). Database Cochrane, Embase, Ovid MEDLINE, WHO COVID-19, NCBI SARS-CoV-2 Resources, Scopus, Web of Science, CINAHL, dan Science Direct telah ditelusuri secara komprehensif tanpa pembatasan bahasa. Kualitas studi yang dimasukkan dinilai menggunakan kriteria Hoy. Data prevalensi dari studi yang dimasukkan diubah menjadi proporsi dan prevalensi gabungan disajikan dalam grafik *forest plot* dengan interval kepercayaan 95% (CI) dan interval prediksi yang sesuai.

Pencarian mengidentifikasi 3,677 artikel, dimana lima belas studi yang melibatkan 9,289 partisipan dimasukkan dalam meta-analisis. Tingkat prevalensi gabungan gejala berduka adalah 44.6% (95% CI: 30.7%-58.5%) dan gangguan berduka diperkirakan sebesar 47.2% (95% CI: 39.8%-54.6%). Usia yang lebih tua lebih rentan terhadap gangguan berduka sebesar 5.00% (95% CI, 1.00%-10.00%), prevalensinya jauh lebih tinggi pada perempuan (28.44%; 95% CI, 19.62%-38.18%), dan gangguan berduka yang didiagnosis dengan alat sensitivitas tinggi (48.99%; 95% CI, 44.33%-53.67%). Hubungan dengan almarhum, waktu setelah kehilangan, alat diagnostik yang berdasarkan spesifikasi, dan risiko bias tidak memengaruhi variabilitas studi yang dimasukkan.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa prevalensi gangguan berduka selama pandemi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi non-pandemi, oleh karena itu penting untuk memperkuat dukungan berduka guna mengurangi stres psikologis. Hasil ini menyoroti dasar dari mana perawat dan tenaga kesehatan perlu mengantisipasi kebutuhan dukungan yang lebih tinggi dan penyediaan perawatan berduka dalam situasi pandemi.

E. Prevalensi *grief disorder* untuk area *pre-loss* (sebelum kematian)

Merawat anggota keluarga dengan penyakit yang mengancam jiwa dapat menyebabkan peningkatan tingkat morbiditas psikologis, termasuk berduka antisipatif sebagai respons terhadap berbagai kehilangan selama periode perawatan. Mengingat kurangnya pengakuan terhadap berduka yang dialami oleh pengasuh, penelitian ini bertujuan untuk menentukan prevalensi gangguan berduka antisipatif pada pengasuh orang dengan penyakit yang mengancam jiwa, guna intervensi dan manajemen yang lebih baik

(Kustanti et al., 2022). CINAHL, Embase, Medline, PubMed, Scopus, PsycINFO, dan Web of Science telah dicari hingga 21 Maret 2021, tanpa pembatasan bahasa. Kualitas studi yang dimasukkan dalam analisis dinilai menggunakan kriteria Hoy. Model efek acak diterapkan untuk menghitung tingkat prevalensi gabungan, dan regresi multivariat dilakukan untuk memeriksa heterogenitas di antara studi-studi tersebut.

Sebanyak 3,278 artikel ditemukan, dan 18 studi memenuhi kriteria kelayakan yang melibatkan 5,470 *caregiver*. Prevalensi gabungan dari berduka antisipatif adalah 24.78% (95% CI, 19.04 hingga 30,99%). Tingkat prevalensi ini secara signifikan lebih tinggi pada *caregiver* perempuan (16.64%; 95% CI, 12.24% hingga 21.53%) dibandingkan dengan *caregiver* laki-laki (6.11%; 95% CI, 4.55% hingga 7.87%). Kelompok yang sudah menikah juga memiliki risiko yang lebih tinggi (14.66%; 95% CI, 10.66% hingga 19.16%) dibandingkan dengan kelompok yang belum menikah (5.47%; 95% CI, 4.31% hingga 6.76%). Kelompok yang lebih muda mengalami berduka lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lebih tua, tetapi hubungan kekerabatan dan kondisi penyakit pasien tidak ditemukan sebagai moderator yang signifikan. Prevalensi gabungan secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berduka pasca-kehilangan pada populasi umum dan mendukung perkiraan bahwa berduka sebelum kehilangan memiliki magnitudo yang lebih besar dibandingkan berduka setelah kehilangan. Dukungan berduka, program edukasi, dan sumber daya terkait harus diberikan bahkan sebelum kehilangan yang sebenarnya untuk mengatasi beban *caregiver*.

BAB 3

SKRINING PROSES BERDUKA

A. Instrumen untuk Proses Berduka

Standar dan kebijakan perawatan paliatif menganjurkan agar dukungan duka cita diberikan kepada pengasuh keluarga, namun masih terdapat ketidakpastian mengenai apakah dukungan yang saat ini ditawarkan oleh layanan perawatan paliatif di seluruh negara maju memenuhi kebutuhan pengasuh. Model kesehatan masyarakat untuk dukungan duka cita, yang menyelaraskan kebutuhan dukungan duka cita dengan intervensi, dapat mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini. Oleh karena itu, Sealey et al. (2015) melakukan suatu penelusuran literatur yang tujuannya adalah meninjau berbagai publikasi untuk mengidentifikasi langkah-langkah penilaian risiko duka yang tepat untuk berbagai titik dalam lintasan perawatan dan duka, mengevaluasi sifat psikometriknya, dan menilai kelayakan untuk digunakan dalam perawatan paliatif.

B. Skrining Berduka Antisipasi

Lima instrumen diidentifikasi oleh Sealey et al. (2015) yang secara khusus dirancang untuk menilai kesedihan sebelum kehilangan. Instrumen tersebut terdiri dari tiga instrumen laporan diri pengasuh dan dua lembar observasi yang dikelola staf.

Instrumen tersebut adalah:

1. *Bereavement Risk Assessment Tool* (BRAT) - Sebuah daftar *checklist* yang dikembangkan oleh profesional

perawatan paliatif Kanada, berdasarkan literatur dan pengalaman klinis, untuk mengidentifikasi faktor risiko dan protektif untuk berkabung. Alat ini memerlukan pelatihan staf dan penilaian subjektif, berfokus pada pengamatan staf daripada masukan langsung dari pengasuh.

2. *Bereavement Risk Index (BRI)* - Daftar *checklist* berisi delapan item yang mudah digunakan dengan reliabilitas memadai, berdasarkan pengamatan staf. Versi modifikasi dengan empat item menunjukkan konsistensi dan validitas prediktif yang lebih baik. Namun, diperlukan adaptasi lebih lanjut untuk penggunaan prospektif.
3. *Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory (MMCGI)* - Alat laporan diri dengan 50 item (dengan bentuk pendek) yang awalnya dibuat untuk pengasuh demensia, menilai pengorbanan pribadi, kesedihan, dan isolasi. Alat ini memiliki konsistensi internal tinggi dan berkorelasi baik dengan ukuran duka dan kesejahteraan lainnya. Alat ini juga efektif untuk pengasuh orang dengan cedera otak dan, dengan modifikasi, untuk pengasuh pasien kanker.
4. *MMCGI-SF*- Versi singkat 18 item dari MMCGI dengan sifat psikometrik serupa, dirancang untuk kemudahan penggunaan.
5. *PG-12-Caregiver*- Alat 12 item yang berasal dari PG-13, ditujukan untuk menyaring risiko *Prolonged Grief Disorder (PGD)* sebelum kematian. Alat ini singkat dan efektif dalam mengidentifikasi pengasuh yang berisiko terkena PGD, seperti yang terlihat di pengaturan hospis.

C. Instrumen Berduka

Sepuluh instrumen proses berduka berdasarkan pengkajian diri, yang dikembangkan untuk berbagai tujuan mulai dari penelitian hingga penilaian klinis, diidentifikasi untuk kemungkinan digunakan guna mengukur kebutuhan dukungan duka dari *caregiver* setelah kematian pasien.

1. *Bereavement Experience Questionnaire* (BEQ-24) - Versi singkat dari BEQ asli untuk menilai kehilangan eksistensial, rasa bersalah/marah, dan ketertarikan pada yang telah meninggal.
2. *Core Bereavement Items* (CBI) - Berasal dari kuesioner sebelumnya, alat ini mengukur duka melalui tiga subskala dan praktis untuk perawatan paliatif, meskipun mungkin tidak dapat mengidentifikasi pengasuh yang berisiko tinggi.
3. *Grief Evaluation Measure* (GEM) - Alat komprehensif untuk klinisi, menilai risiko duka rumit namun terlalu panjang untuk digunakan dalam perawatan paliatif.
4. *Grief Experience Questionnaire* (GEQ) - Awalnya dikembangkan untuk membedakan duka pada kasus bunuh diri, namun juga dapat diterapkan pada jenis duka lainnya meskipun membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk penggunaan di perawatan paliatif.
5. *Hogan Grief Reaction Checklist* (HGRC) - Dikembangkan untuk orang tua yang berduka, namun kompleksitasnya membatasi penggunaannya dalam perawatan paliatif.
6. *Revised Grief Experience Inventory* (R-GEI) - Versi lebih pendek dari GEI, mencakup kekhawatiran eksistensial, depresi, ketegangan, dan stres fisik; berguna untuk duka rutin tetapi tidak ideal untuk mengidentifikasi pengasuh yang berisiko.

7. *Inventory of Traumatic Grief* (ITG) - Berfokus pada duka patologis melalui pemisahan dan stres traumatis, merupakan pengembangan dari *Inventory of Complicated Grief* (ICG).
8. *Texas Revised Inventory of Grief* (TRIG) - Mengukur duka yang belum terselesaikan melalui perasaan masa lalu dan masa kini, umum digunakan untuk pengasuh di rumah sakit.
9. *Two-Track Bereavement Questionnaire* (TTBQ) - Mengukur duka seiring waktu dalam dua domain: fungsi biopsikososial dan hubungan yang berkelanjutan dengan almarhum. Baru-baru ini disingkat untuk kemungkinan penggunaan dalam perawatan paliatif.
10. Instrumen Lain - Berbagai alat lain seperti IES-R, BPQ, dan GMS tidak digunakan atau dikecualikan karena fokus pada trauma daripada duka.

D. Instrumen Berduka Terkomplikasi

Empat instrumen berdasarkan laporan diri dikembangkan secara khusus untuk kesedihan yang rumit atau berkepanjangan, dan mungkin cocok untuk menilai penyesuaian yang buruk terhadap kesedihan enam bulan pasca kematian dan seterusnya. Tiga dari ukuran ini dikembangkan dari penelitian yang menentukan bagaimana gejala kesedihan yang rumit atau berkepanjangan berbeda dari kesedihan 'normal', serta depresi dan kecemasan.

Instrumennya adalah:

1. *Inventory of Complicated Grief* (ICG) dan versi revisinya 15-item (ICG-R) - Dikembangkan untuk menilai kesedihan yang rumit yang berbeda dari kesedihan normal, depresi, dan kecemasan, serta digunakan secara luas di berbagai populasi yang berduka, termasuk kehilangan pasangan

dan orang tua, berduka akibat trauma dan bunuh diri, serta di setting perawatan kesehatan mental, perawatan intensif, perawatan paliatif, dan onkologi.

2. *Prolonged Grief Disorder* (PG-13) - Sebuah algoritma untuk mendiagnosis reaksi berduka berkepanjangan (*Prolonged Grief Disorder*), diterapkan dalam berbagai konteks penelitian seperti populasi pengungsi dan pengasuh pasien Penyakit Saraf Motorik (*Motor Neurone Disease/MND*).
3. *Brief Grief Questionnaire* (BGQ), juga dikenal sebagai *Brief Complicated Grief Questionnaire* (BCGQ) - Dibat sebagai alat skrining singkat untuk kesedihan rumit setelah serangan 9/11, dan digunakan dalam studi lintas budaya, termasuk sampel besar di Jepang, yang menunjukkan sifat psikometrik yang dapat diandalkan di berbagai studi.

BAB 4

DIAGNOSIS & INTERVENSI PROSES BERDUKA

A. Jenis Berduka

Pada konsep kehilangan dan berduka, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami secara menyeluruh meliputi *loss*, *grief*, *mourning*, dan *bereavement* (**Tabel 4.1**).

Tabel 4.1: Definisi terminology terkait kehilangan dan berduka

Terminologi	Definisi
Kehilangan (<i>loss</i>)	Hilangnya kepemilikan ditandai dengan respons kesedihan dan ekspresi berkabung
Duka (<i>grief</i>)	Respons emosional terhadap kehilangan, didefinisikan sebagai perasaan dan respons individual yang dialami oleh seseorang terhadap kehilangan nyata, dirasakan, atau diantisipasi
Berduka (<i>mourning</i>)	Ekspresi lahiriah, sosial dari kehilangan
Berkabung (<i>bereavement</i>)	Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman anggota keluarga dan teman pada periode sebelum, selama, dan setelah kematian orang yang dicintai

Berduka normal mencakup perasaan, perilaku, dan reaksi umum terhadap kehilangan. Reaksi kesedihan akibat

kehilangan dapat memakan waktu bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada jenis kehilangan. Perasaan kehilangan tidak dapat hilang sepenuhnya, namun pada akhirnya setiap individu akan terhubung kembali dengan dunia nyata saat hubungan dengan almarhum berubah.

Berduka akut dimulai segera setelah kematian orang yang dicintai dan termasuk respons perpisahan dan respons terhadap stres. Selama periode kesedihan akut ini, individu yang berkabung mengalami kebingungan akan identitas atau peran sosial mereka. Individu cenderung melepaskan diri dari aktivitas rutin dan merasa tidak percaya bahwa orang yang mereka cintai telah tiada.

Berduka antisipatif didefinisikan sebagai kesedihan sebelum kehilangan, terkait dengan diagnosis penyakit akut, kronis, dan/atau terminal yang dialami oleh individu, keluarga, atau pengasuh. Berduka antisipatif dimulai pada saat diagnosis terminal dan dapat berlanjut sampai orang tersebut meninggal. Baik individu maupun anggota keluarga dapat merasakan berduka jenis ini. Pasien dapat merasa kehilangan kemandirian, fungsi, atau kenyamanan, sehingga menyebabkan rasa sakit dan kecemasan yang signifikan jika tanpa dukungan yang tepat. Individu mungkin juga memiliki kesedihan tentang hilangnya pengalaman keluarga yang diantisipasi, seperti merayakan pernikahan seorang anak, kelahiran cucu, ulang tahun, atau peristiwa penting lainnya dalam hidup. Berduka antisipasi pada keluarga dapat terjadi akibat kehilangan orang yang mereka cintai sebelum mereka meninggal saat mereka membayangkan hidup mereka tanpa orang yang mereka cintai di dalamnya.

Berduka terselubung merupakan jenis berduka yang tidak dapat divalidasi atau diakui. Individu yang terkena dampak kesedihan semacam ini tidak merasakan kebebasan untuk secara terbuka mengakui kesedihan mereka. Individu yang berisiko mengalami tipe berduka ini biasanya adalah mereka yang kehilangan orang yang dicintai karena penyakit atau peristiwa yang distigmatisasi, seperti AIDS. Ibu dan/atau ayah mungkin berduka atas kehamilan yang dihentikan atau bayi yang lahir mati, hilangnya hubungan atau perceraian.

B. Diagnosa Prolonged Grief Disorder

Proses berduka telah menjadi bagian dalam pembelajaran tenaga kesehatan profesional sejak lama. Namun, berduka baru diakui sebagai diagnosa sejak 2022. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* atau yang lebih dikenal dengan ICD telah memasukkan diagnosa *Prolonged grief disorder* (PGD) pada edisi 11 pada bagian gangguan akibat stress (WHO, 2021). Sedangkan the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) yang pada mulanya memasukkan diagnosa *Persistent complex bereavement disorder* (PCBD) pada edisi 5 telah menggantinya menjadi PGD pada edisi DSM-5-TR (APA, 2022).

Diagnosa PGD memiliki kriteria berbeda pada ICD 11 dan DSM-5-TR. DSM menetapkan kriteria yang lebih ketat terutama terkait durasi munculnya gejala. Sedangkan ICD-11 cenderung lebih longgar dalam menegakkan diagnosa PGD. Kondisi ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penetapan kriteria yang tidak ketat berdampak pada tingginya angka kejadian PGD yang

ditemukan dilapangan. Hal ini tentunya dapat berdampak pada estimasi kejadian yang berlebihan. Sebaliknya, penetapan kriteria yang terlalu ketat dapat berdampak pada kemungkinan tidak terjangrnya individu yang pada kenyataannya memang memiliki masalah PGD. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan prevalensi individu dengan diagnosa PGD menggunakan kriteria ICD dan DSM (Boelen et al., 2018; Rosner et al., 2021). Kriteria diagnosa berdasarkan ICD 11 dan DSM-5-TR tergambar secara detail di **Tabel 2**.

Tabel 2
Kriteria diagnosa Prolonged grief disorder (PGD)

Kriteria	ICD 11	DSM-5-TR
A	Gangguan muncul setelah kematian pasangan, orang tua, anak, atau sosok lain yang dekat dengan orang yang berduka	Kematian seseorang yang dekat <i>setidaknya 12 bulan</i> sebelumnya
B	Respon kesedihan yang persisten dan meresap ditandai dengan kerinduan pada almarhum atau keasyikan yang terus-menerus	Sejak kematian, terdapat respons kesedihan yang ditandai oleh <i>salah satu atau kedua gejala</i> berikut, Hingga pada level klinis yang signifikan, hampir setiap hari atau lebih selama

	dengan almarhum	sedikitnya dalam <i>sebulan terakhir</i> : 1. Kerinduan/kerinduan yang kuat untuk orang yang telah meninggal 2. Keasyikan dengan pikiran atau kenangan orang yang meninggal
C	Muncul gejala kepedihan emosional yang intens, seperti: 1. Kesedihan 2. Rasa bersalah 3. Marah 4. Menolak kehilangan 5. Menyalahkan 6. Sulit menerima kematian 7. Merasa bagian dari dirinya telah mati 8. Tidak mampu mengalami mood yang positif 9. Mati rasa 10. Mengalami kesulitan untuk terlibat	Sebagai dampak dari kehilangan, paling tidak mengalami sedikitnya 3 dari 8 gejala sejak kematian. Gejala dirasakan hamper setiap hari atau selih selama satu bulan terakhir: 1. Gangguan identitas (misalnya, merasa seolah-olah bagian dari diri sendiri telah meninggal) 2. Tidak percaya akan kematian 3. Menghindari segala hal yang dapat meningkatkan pada individu yang meninggal 4. Merasakan kepedihan emosional yang intens (marah, kesedihan mendalam) yang berhubungan dengan kematian.

	dalam kegiatan sosial	5. Mengalami kesulitan untuk kembali ke kehidupan nyata setelah ekmatian (mis. Sulit untuk merasa terhubung dengan teman, tidak tertarik melakukan apapun, atau bahkan tidak mampu memikirkan masa depan) 6. Mati rasa (intensitas emosional rendah, membatu) sebagai dampak dari kematian 7. Merasa hidup tidak bermakna sebagai dampak dari kematian 8. Perasaan kesepian (merasa sendiri, terpisah dari orang kebanyakan) sebagai dampak dari kematian
D	Respons berduka dialami dalam jangka waktu yang tidak biasa setelah kehilangan (minimal lebih dari 6 bulan) melebihi norma	Gangguan menyebabkan distress klinis signifikan pada aspek kehidupan sosial, pekerjaan, atau fungsi-fungsi pada area penting lainnya.

	sosial, budaya atau agama yang berlaku. Reaksi berduka dalam rentang waktu sesuai nilai-nilai norma, budaya, dan agama yang berlaku dianggap dalam batasan normal sehingga tidak perlu mendapatkan diagnosa	
E	Gangguan menyebabkan gangguan signifikan pada kehidupan personal, keluarga, sosial, Pendidikan, atau pada fungsi-sungsi penting pada area penting lainnya.	Durasi dan tingkat keparahan reaksi berduka jelas melebihi norma sosial, budaya, atau agama yang diharapkan untuk budaya dan konteks individu
F		Gejalanya tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan depresi mayor, gangguan

		stres pascatrauma, atau gangguan mental lainnya, atau disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat (misalnya, obat-obatan, alkohol) atau kondisi medis lainnya.
--	--	---

Apabila ditelusur secara teliti, kedua sumber diagnosa memiliki perbedaan spesifik terkait durasi. Perbedaan terletak bukan pada durasi untuk aspek yang sama. ICD 11 menekankan durasi 6 bulan untuk kemunculan gejala. Oleh karena itu, untuk menegakkan diagnosa PGD, tenaga kesehatan klinis atau peneliti yang menggunakan ICD 11 sebagai referensi harus mampu mengkaji awal gejala berduka muncul tanpa mempertimbangkan lama waktu kehilangan. Sedangkan DSM-5-TR menekankan durasi 12 bulan untuk waktu kehilangan. Sehingga secara kasar dapat diprediksi bahwa diagnosa PGD ditegakkan apabila kehilangan telah lebih dari 12 bulan tanpa mempertimbangkan lama munculnya gejala berduka.

Berdasarkan waktu kehilangan, berduka dapat bersifat aktual atau potensial. Berduka aktisipatif merujuk pada respon akibat kehilangan potensial atau kehilangan yang belum terjadi. Kehilangan biasanya terkait dengan diagnosis penyakit akut, kronis, dan/atau terminal yang dialami oleh individu, keluarga, atau pengasuh. Berduka antisipatif dimulai pada saat diagnosis terminal dan dapat berlanjut sampai orang tersebut meninggal.

C. Diagnosa Keperawatan Respon Berduka

Berbeda dengan ICD 11 dan DSM-5-TR yang menggunakan terminologi sama untuk menegaskan diagnosa respon berduka, PGD, keilmuan keperawatan memiliki terminologi yang berbeda. Diagnosa keperawatan merujuk pada beberapa sumber yang tentunya juga memiliki diagnosa berbeda. Berdasarkan *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). Terminologi diagnosa respon berduka telah mengalami evolusi, hingga berdasarkan NANDA tahun 2024-2026, diagnosa respon berduka terdiri atas: 1) Berduka maladaptif; 2) Resiko berduka maladaptif; dan 3) kesiapan peningkatan respon berduka. Sedangkan berdasarkan standa diagnosa keperawatan Indonesia (SDKI), respon berduka digambarkan pada satu diagnosa yaitu berduka (**Tabel 3**). SDKI tidak membedakan berduka menjadi kondisi yang fisiologis atau patologis. Perbedaan ini dapat memicu perbedaan dalam melihat respon berduka. Respon berduka yang mungkin dianggap normal berdasarkan NANDA menjadi abnormal jika dilihat dari sudut pandang SDKI. Sebagaimana perbedaan ICD 11 dan DSM-5-TR dapat menyebabkan perbedaan angka kejadian berduka pada individu yang mengalami kehilangan. Bila dilihat lebih jauh, SDKI dicetak pada periode diagnosa PGD belum ditegakkan oleh ICD dan DSM. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan diagnosa hingga dapat berjalan selaras dengan sumber-sumber referensi diagnosa lainnya.

Tabel 3
Diagnosa respon berduka berdasarkan NANDA dan SDKI

Sumber	NANDA 2024-2026		
Diagnosa	Berduka Maladaptif	Resiko Berduka Maladaptif	Kesiapa peningka respon ber
Definisi	Gangguan yang muncul setelah kehilangan orang yang berarti dengan respon berduka yang tidak sesuai ekpektasi norma sosial dan budaya yang berlaku	Berisiko mengalami gnagguan setelah kehilangan orang yang berarti dengan respon berduka yang tidak sesuai ekpektasi norma sosial dan budaya yang berlaku dan dapat menyebabkan masalah kesehatan	Pola fungsi kehidupan b yang muncul setelah kehil aktual, antisi atau signifika dapat dipertahanka ditingkatkan
Gejala	• Cemas • Penurunan peran • Gejala depresi • Tidak mampu membina hubungan yang lekat • Krisis kepercayaan • Stress berlebihan • Mengalami gejala yang dirasakan subjek yg meninggal • Marah	-	• Menunjukkeinginan m meneruska nila pening subjek yan meninggal • Menunjukkeinginan m terlibat dal aktivitas • Berusaha mengguna mekanisme koping unt

- Merasa lelah
- Distress terkait subjek yang hilang
- Perasaan terasing, kosong, diabaikan, termangu, kaget, fatigue
- Mengalami gejala gangguan pencernaan,
- Menghindar
- Mengalami gangguan fisik
- Rindu dengan subjek yang hilang
- Tidak percaya orang lain
- Tidak menerima kematian
- Ingatan yang menyakitkan
- Menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan subjek yang hilang
- Mengingat kembali

- mengatasi kepedihan
- Bersikap memaafkan
- Berusaha memperbaiki siklus tidur
- Memahami perasaan dan keputusan rasa bersalah, penyesalan, perasaan p
- Mengenal kenangan bersama su
- Berusaha menjalani kehidupan menyenangkan, memaknai kehidupan, mencoba p dengan hie menerima kehilangan
- Menggunakan energi untuk menjalani kehidupan ini

	kenangan Bersama subjek yang hilang • Mencari subjek yang hilang • Menyalahkan diri sendiri		
Etiologi	• Kesulitan menerima kehilangan • Gangguan emosional yang berlebihan • Mudah cemas • Dukungan sosial minimal • Kemampuan menghindari rendah	• Kesulitan menerima kehilangan • Gangguan emosional yang berlebihan • Mudah cemas • Dukungan sosial minimal • Kemampuan menghindari rendah	-
Faktor resiko	• Kesulitan ekonomi • Riwayat kesulitan menerima kehilangan sebelumnya • Riwayat kehilangan mendadak	• Kesulitan ekonomi • Riwayat kesulitan menerima kehilangan sebelumnya • Riwayat kehilangan mendadak • Riwayat kehilangan akibat kekerasan	-

	• Riwayat kehilangan akibat kekerasan • Tidak puas dengan pesan kematian • Melihat anggota keluarga dengan respon berduka maladaptive	• Tidak puas dengan pesan kematian • Melihat anggota keluarga dengan respon berduka maladaptive • Riwayat kekerasan masa kanak-kanak • Riwayat berduka yang tidak tuntas • Ketergantungan tinggi dengan subjek yang hilang • Memiliki kerentanan tinggi untuk berduka • Memiliki konflik yang belum selesai dengan subjek yang hilang • Tidak bekerja • Wanita
Comorbidity yang mungkin menyertai		• Gangguan kecemasan • Depresi
catatan	Gejala muncul sedikitnya 6 bulan	

D. Intervensi respon berduka

Ragam intervensi dapat diberikan kepada individu dengan respon berduka maladaptive atau PGD.

Psikoterapi

Behavioural therapy (BT), *Complicative grief treatment* (CGT), *cognitive behaviour therapy* (CBT), *family therapy*, *cognitive therapy* (CT), *support group therapy* (SGT) terbukti efektif dalam menurunkan gejala berduka. Hasil penelitian network meta-analysis menunjukkan bahwa Terapi psikodinamik terbukti lebih efektif dan lebih diterima dibandingkan dengan intervensi lainnya, sementara terapi CBT gelombang ketiga dan terapi perilaku cenderung kurang diterima oleh pasien. Selain itu, tinjauan kami juga menunjukkan bahwa tingkat depresi, gejala PTSD, dan kecemasan pada orang dewasa perlu dipertimbangkan dalam keputusan mengenai penerapan psikoterapi.

Setiap psikoterapi mengatasi gejala berduka dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Terapi psikoterapi yang memfasilitasi penerimaan terhadap kehilangan sekaligus meningkatkan ketahanan emosional, terbukti lebih efektif dan banyak digunakan. CBT dan BT meningkatkan strategi koping untuk mengatasi berduka. Hasil analisa menunjukkan CBT mengurangi gejala berduka secara signifikan dibandingkan dengan terapi interpersonal dan SGT. SGT terbukti dapat membantu mengurangi intensitas berduka akut, namun tidak cukup efektif untuk menangani PGD yang lebih kompleks. Terapi psikodinamik sering digunakan untuk mengurangi penderitaan psikologis dan meningkatkan kualitas hidup individu yang berduka secara

lebih luas. Dengan demikian, pilihan terapi yang tepat sangat bergantung pada tingkat dan kompleksitas gejala yang dialami individu, serta respons mereka terhadap jenis terapi tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan pendekatan psikoterapi yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien untuk hasil yang lebih optimal dalam pengobatan berduka.

Terapi Farmaka

Penelitian mengenai pengobatan farmakologis untuk gangguan respon berduka yang berkepanjangan atau maladaptif masih terbatas. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa antidepresan dapat mengurangi gejala depresi pada individu yang berduka, namun efeknya terhadap intensitas berduka sangat terbatas. Penelitian dengan desain randomised controlled trial (RCT) menunjukkan nortriptyline berhasil mengurangi gejala depresi.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggunaan antidepresan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terapi CBT dan mengurangi ketidaktuntasan terapi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi target pengobatan farmakologis yang berbasis bukti untuk mengatasi PGD, serta untuk memahami dampak penggunaan obat-obatan tertentu, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi dengan terapi psikoterapi.

Intervensi Keperawatan

Asuhan keperawatan untuk pasien dengan respon berduka maladaptif atau PGD di NANDA *nursing intervention classification* (NIC) (**Tabel 4**) merupakan

kombinasi intervensi memfasilitasi proses berduka, menyalurkan kemarahan, penumbuhan harapan, dan mengatasi berduka akibat kehilangan anak.

Tabel 4.1: *Intervensi PGD berdasarkan NANDA*

Fokus asuhan	Intervensi
<i>Berduka maladaptif</i>	
Umum	<i>Berduka aktual</i> • Identifikasi gejala berduka maladaptive yang muncul minimal selama enam bulan setelah kematian atau kehilangan. Gejala harus muncul setidaknya setiap hari atau dalam batasan yang mengganggu • Tentukan tahapan berduka pasien. Gunakan instrument standar yang sesuai • Gunakan Teknik komunikasi mendengar aktif • Identifikasi perasaan berduka pasien • Berikan individu yang berduka waktu dan ruang untuk sendiri • Ekspresikan rasa turut berduka atas kehilangan pasien • Identifikasi adanya depresi, kecenderungan untuk bunuh diri, atau gangguan emosi lainnya • Edukasi pasien dan penyedia dukungan pasien bahwa hindari Upaya untuk menghilangkan subjek dari kehidupan. Sebaiknya, jalan keluar dari berduka adalah dengan tetap menjadikan subjek yang hilang menjadi bagian dari kehidupan • Identifikasi adanya pikiran pesimis dan kejadian pemicu stress terutama pada caregiver yang lebih muda • Buat jadwal pertemuan dengan pasien untuk memberikan dukungan

- Bantu individu mengekspresikan rasa kehilangan menggunakan metode yang sesuai
- Diskusikan metode koping yang bisa digunakan
- Anjurkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang tenang untuk memfasilitasi respon berduka
- Bantu individu dan keluarga untuk menemukan kelompok dukungan berduka
- Rujuk individu dan keluarga ke konseling spiritual

Berduka antisipasi

- Identifikasi adanya perasaan berduka akibat penyakit terminal, potensial kehilangan anggota keluarga atau kehilangan hal yang berarti
- Bina hubungan saling percaya dengan pasien dan pengasuh
- Berikan informasi terbaru pasien setiap hari pada keluarga atau pengasuh. Selalu berkonsultasi dengan keluarga dalam setiap pengambilan keputusan
- Berikan informasi terkait perawatan yang diperlukan oleh pasien setiap hari kepada keluarga atau pengasuh. Berikan informasi terkait pilihan. Yang dimiliki oleh pasien dalam menghadapi kematian, termasuk perawatan paliatif, jenazah, dan perawatan rumah.
- Identifikasi ketercukupan sumber untuk perawatan pasien, keluarga
- Motivasi keluarga untuk menunjukkan kepedulian dan berbicara dengan pasien setiap hari
- Kenali dan hargai perasaan pasien dan keluarga

	• Jika dibutuhkan, konsultasikan keluarga dengan pakar kesehatan mental atau pemuka agama untuk memfasilitasi kebutuhan mereka • Dorong keluarga untuk melakukan pengambilan Keputusan secara musyawarah
Anak/orang tua	• Rujuk anak atau orang tua yang mengalami kehilangan untuk mengikuti program yang memfasilitasi proses berduka • Motivasi orang tua yang mengalami kehilangan untuk terlibat dalam aktivitas positif seperti kelompok dukungan spiritual • Motivasi orang tua yang mengalami kehilangan untuk menemui pakar kesehatan jiwa • Jika pasien adalah remaja yang mengalami kehilangan, maka dorong remaja untuk menemukan kelompok dukungan yang sesuai
Lansia	• Identifikasi adanya masalah perawatan diri akibat kehilangan • Individu yang hidup dengan lansia dengan demensia dan memiliki riwayat kehilangan sebelumnya akan mengalami respon berduka yang lebih intens setelah kematian lansia tersebut • Pantau tanda dan gejala fisik serta mental berduka kompleks
Multi budaya	• Identifikasi adanya variasi nilai atau keyakinan budaya terkait respon berduka akibat kehilangan • Dorong adanya diskusi terkait kehilangan dan berduka yang dialami • Identifikasi apakah individu memahami kondisi pasien dan bersedia untuk menemani sela aproses menjelang kematian
Perawatan rumah	• Semua bentuk intervensi dapat dilakukan di tatanan rumah

	• Bila tersedia fasilitas terkait, diskusi dan konsultasi dapat dilakukan via internet
<i>Resiko Berduka maladaptif</i>	
Umum	<i>Berduka aktual</i> • Identifikasi gejala berduka maladaptive yang muncul minimal selama enam bulan setelah kematian atau kehilangan. Gejala harus muncul setidaknya setiap hari atau dalam batasan yang mengganggu • Tentukan tahapan berduka pasien. Gunakan instrument standar yang sesuai • Gunakan Teknik komunikasi mendengar aktif • Identifikasi perasaan berduka pasien • Berikan individu yang berduka waktu dan ruang untuk sendiri • Ekspresikan rasa turut berduka atas kehilangan pasien • Identifikasi adanya depresi, kecenderungan untuk bunuh diri, atau gangguan emosi lainnya • Edukasi pasien dan penyedia dukungan pasien bahwa hindari Upaya untuk menghilangkan subjek dari kehidupan. Sebaiknya, jalan keluar dari berduka adalah dengan tetap menjadikan subjek yang hilang menjadi bagian dari kehidupan • Identifikasi adanya pikiran pesimis dan kejadian pemicu stress terutama pada caregiver yang lebih muda • Buat jadwal pertemuan dengan pasien untuk memberikan dukungan • Bantu individu mengekspresikan rasa kehilangan menggunakan metode yang sesuai • Diskusikan metode koping yang bisa digunakan

- Anjurkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang tenang untuk memfasilitasi respon berduka
- Bantu individu dan keluarga untuk menemukan kelompok dukungan berduka
- Rujuk individu dan keluarga ke konseling spiritual

Berduka antisipasi

- Identifikasi adanya perasaan berduka akibat penyakit terminal, potensial kehilangan anggota keluarga atau kehilangan hal yang berarti
- Bina hubungan saling percaya dengan pasien dan pengasuh
- Berikan informasi terbaru pasien setiap hari pada keluarga atau pengasuh. Selalu berkonsultasi dengan keluarga dalam setiap pengambilan keputusan
- Berikan informasi terkait perawatan yang diperlukan oleh pasien setiap hari kepada keluarga atau pengasuh. Berikan informasi terkait pilihan. Yang dimiliki oleh pasien dalam menghadapi kematian, termasuk perawatan paliatif, jenazah, dan perawatan rumah.
- Identifikasi ketercukupan sumber untuk perawatan pasien, keluarga
- Motivasi keluarga untuk menunjukkan kepedulian dan berbicara dengan pasien setiap hari
- Kenali dan hargai perasaan pasien dan keluarga
- Jika dibutuhkan, konsultasikan keluarga dengan pakar kesehatan mental atau pemuka agama untuk memfasilitasi kebutuhan mereka
- Dorong keluarga untuk melakukan pengambilan Keputusan secara musyawarah

Anak/orang tua	• Rujuk anak atau orang tua yang mengalami kehilangan untuk mengikuti program yang memfasilitasi proses berduka • Motivasi orang tua yang mengalami kehilangan untuk terlibat dalam aktivitas positif seperti kelompok dukungan spiritual • Motivasi orang tua yang mengalami kehilangan untuk menemui pakar kesehatan jiwa Jika pasien adalah remaja yang mengalami kehilangan, maka dorong remaja untuk menemukan kelompok dukungan yang sesuai
Lansia	• Identifikasi adanya masalah perawatan diri akibat kehilangan • Individu yang hidup dengan lansia dengan demensia dan memiliki riwayat kehilangan sebelumnya akan mengalami respon berduka yang lebih intens setelah kematian lansia tersebut Pantau tanda dan gejala fisik serta mental berduka kompleks
Multi budaya	• Identifikasi adanya variasi nilai atau keyakinan budaya terkait respon berduka akibat kehilangan • Dorong adanya diskusi terkait kehilangan dan berduka yang dialami Identifikasi apakah individu memahami kondisi pasien dan bersedia untuk menemani sela aproses menjelang kematian
Perawatan rumah	• Semua bentuk intervensi dapat dilakukan di tatanan rumah • Bila tersedia fasilitas terkait, diskusi dan konsultasi dapat dilakukan via internet
<i>Kesiapan peningkatan respon berduka</i>	
	<i>Berduka antisipasi</i>

- Identifikasi adanya perasaan berduka akibat penyakit terminal, potensial kehilangan anggota keluarga atau kehilangan hal yang berarti
- Bina hubungan saling percaya dengan pasien dan pengasuh
- Berikan informasi terbaru pasien setiap hari pada keluarga atau pengasuh. Selalu berkonsultasi dengan keluarga dalam setiap pengambilan keputusan
- Berikan informasi terkait perawatan yang diperlukan oleh pasien setiap hari kepada keluarga atau pengasuh. Berikan informasi terkait pilihan. Yang dimiliki oleh pasien dalam menghadapi kematian, termasuk perawatan paliatif, jenazah, dan perawatan rumah.
- Identifikasi ketercukupan sumber untuk perawatan pasien, keluarga
- Motivasi keluarga untuk menunjukkan kepedulian dan berbicara dengan pasien setiap hari
- Kenali dan hargai perasaan pasien dan keluarga
- Jika dibutuhkan, konsultasikan keluarga dengan pakar kesehatan mental atau pemuka agama untuk memfasilitasi kebutuhan mereka
- Dorong keluarga untuk melakukan pengambilan Keputusan secara musyawarah

Berduka kehilangan aktual

- Gunakan Teknik komunikasi mendengar aktif
- Identifikasi perasaan berduka pasien
- Berikan individu yang berduka waktu dan ruang untuk sendiri
- Ekspresikan rasa turut berduka atas kehilangan pasien

	• Buat jadwal pertemuan dengan pasien untuk memberikan dukungan • Bantu individu mengekspresikan rasa kehilangan menggunakan metode yang sesuai • Diskusikan metode koping yang bisa digunakan • Anjurkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang tenang untuk memfasilitasi respon berduka • Bantu individu dan keluarga untuk menemukan kelompok dukungan berduka • Rujuk individu dan keluarga ke konseling spiritual
Anak/orang tua	• Hargai anak atau orang tua, berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan jawab pertanyaan dengan jujur • Dengarkan ekspresi berduka anak • Edukasi orang tua bahwa berduka pada anak tidak harus diatasi, sebaliknya mereka perlu menghadapi respon kehilangan sebagaimana individu dewasa • Gunakan metode bermain atau seni untuk menjelaskan tentang kematian, resiko kehilangan orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya • Rujuk anak atau orang tua yang berduka ke tenaga kesehatan mental terutama bila kematian bersifat traumatic • Fasilitasi remaja untuk mengidentifikasi sumber dukungan sosial dan diskusikan strategi untuk mendapatkan dukungan • Motivasi. Orang tua yang berduka untuk menjaga kesehatan mereka • Rujuk orang tua yang berduka ke tenaga kesehatan jiwa professional jika dibutuhkan

	• Kenali pola berduka yang berbeda antara laki-laki dan wanita, karenanya edukasi orang tua terkait hal ini • Kenali kemungkinan berduka bagi ibu yang mengalami keguguran
Lansia	• Pantau kemungkinan kemunculan kembali berduka pada lansia • Berikan dukungan pada keluarga terutama bila subjek yang meninggal adalah lansia dengan demensia • Identifikasi dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lansia yang berduka
Multi budaya	• Identifikasi adanya variasi nilai atau keyakinan budaya terkait respon berduka akibat kehilangan • Dorong adanya diskusi terkait kehilangan dan berduka yang dialami • Identifikasi apakah individu memahami kondisi pasien dan bersedia untuk menemani sela aproses menjelang kematian
Perawatan rumah	• Intervensi yang telah dipaparkan dapat digunakan di tatanan perawatan rumah • Identifikasi pola kegiatan selama dirumah • Dengarkan secara aktif perasaan berduka pasien atas kematiannya sendiri, atau akibat kehilangan orang lain • Kenali gejala berduka yang dialami, • Gunakan pendekatan peduli dan penuh harapan • Rujuk individu untuk pelayanan sosial • Libatkan pasien dalam kegiatan dukungan mental bagi individu yang berduka dimasing-masing rumah sakit

BAB 5

KOMPLIKASI GANGGUAN BERDUKA

Berduka merupakan reaksi normal yang dirasakan oleh setiap individu yang mengalami kehilangan. *Prolonged grief disorder* (PGD) merupakan respon berduka yang melebihi batas normal berdasarkan norma, budaya dan agama. Respon berduka yang memanjang dan bersifat patologis tentunya berdampak pada sistem tubuh baik secara fisik maupun psikologis.

Secara fisik, berduka memanjang dan patologis dapat berpengaruh pada sistem endokrin, kualitas tidur, perubahan hemodinamik, imunitas, dan pembekuan darah.

1. Gangguan endokrin

Individu dengan respon berduka cenderung mengalami peningkatan kadar kortisol dalam darah. Peningkatan terjadi pada 10 hingga 11 hari paska kehilangan. Kadar kortisol lebih tinggi pada pria jika dibandingkan dengan wanita. Peningkatan kadar tetap terjadi bahkan hingga enam bulan setelah kehilangan. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung, penurunan kualitas hidup dan gangguan imunitas tubuh.

2. Perubahan kualitas tidur

Gangguan tidur merupakan masalah yang umum dialami oleh individu yang berduka, terutama bila disertai depresi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian menggunakan analisa elektroensefalologi yang menunjukkan hasil yang sama. Gangguan tidur seringkali dikaitkan dengan adanya gangguan kognitif seperti pikiran intrusif dan perilaku menghindar.

Gangguan tidur dapat berlangsung lama, namun seiring waktu masalah ini dapat hilang dan kembali sebagaimana sebelum kehilangan terjadi. Karenanya perlu dipertimbangkan pemberian terapi tambahan untuk membantu pasien meningkatkan kualitas tidur individu yang mengalami respon berduka.

3. Perubahan hemodinamik

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berduka cenderung memiliki tekanan darah sistolik yang lebih tinggi. Namun, seiring waktu, tekanan darah cenderung kembali normal setelah beberapa tahun. Meskipun perubahan hemodinamik jangka pendek mungkin tidak signifikan bagi individu muda yang sehat, perubahan kecil pada tekanan darah dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular pada individu yang lebih tua atau yang sudah memiliki penyakit jantung. Oleh karena itu, pengendalian tekanan darah selama masa berduka bisa menjadi strategi pencegahan penting, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi.

4. Imunitas

Fungsi kekebalan tubuh merupakan salah satu perubahan fisiologis yang paling banyak dipelajari pada masa berduka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berduka dapat menyebabkan penurunan respons limfosit T terhadap stimulasi, meskipun jumlah absolut limfosit tidak selalu terpengaruh. Penurunan aktivitas sel pembunuh alami (*Natural Killer*), yang berfungsi melawan tumor dan infeksi virus, juga mengalami perubahan terutama bila disertai depresi atau insomnia. Berduka yang tidak terselesaikan dalam jangka panjang dapat menurunkan respons imun. Perubahan imun yang signifikan terjadi 1-2 bulan setelah kehilangan. Fungsi imun kembali normal enam bulan setelah

kehilangan, kecuali pada individu dengan berduka yang belum terselesaikan.

5. Gangguan pembekuan darah

Peningkatan kadar Von Willebrand factor (vWF) dan aktivasi platelet telah teramati pada minggu-minggu awal berduka, yang keduanya kembali normal dalam enam bulan. Aktivasi platelet yang meningkat dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kardiovaskular, terutama bagi individu dengan faktor risiko yang sudah ada sebelumnya.

6. Kematian

Banyak penelitian mendukung gagasan bahwa berduka dapat meningkatkan risiko mortalitas, khususnya meningkatkan risiko terjadinya peristiwa kardiovaskular dan serebrovaskular. Jalur biologis yang dapat menjelaskan peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat berduka terjadi akibat peningkatan kadar kortisol, disfungsi sistem imun, dan peradangan seluler.

Meskipun beberapa studi belum menemukan hubungan yang signifikan atau hasil yang tidak konsisten, banyak penelitian lainnya menunjukkan adanya kaitan antara morbiditas medis dan berbagai jenis kehilangan. Sebagai contoh, risiko kematian lebih tinggi pada mereka yang mengalami kehilangan akibat kematian mendadak. Sebuah penelitian yang mengikuti lebih dari 170.000 pasien perawatan primer yang berusia di atas 60 tahun selama rata-rata empat tahun menemukan bahwa risiko kematian dalam setahun lebih tinggi secara substansial pada mereka yang mengalami kehilangan akibat kematian mendadak (OR 1,61) dibandingkan dengan kehilangan yang diperkirakan (OR 1,21).

Secara psikologis, individu berduka yang mengalami PGD cenderung menunjukkan gangguan mental lanjutan.

1. Kesepian

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami kehilangan anggota keluarga cenderung mengembangkan perasaan kesepian yang pada gilirannya dapat berperan dalam perkembangan masalah kesehatan mental terkait kehilangan, seperti depresi. Kesepian emosional merupakan bentuk kesepian yang dialami oleh individu yang berduka. Individu yang merasa kesepian cenderung melihat dunia sosial sebagai tempat yang mengerikan dan negative. Kesepian ini seringkali terkait dengan peningkatan gejala depresi serta pemikiran dan perilaku bunuh diri.

Penelitian telah menunjukkan bahwa kesepian menjadi titik awal depresi dan masalah mental lainnya pada orang yang sedang berduka. Salah satu survei yang melibatkan 208 orang dewasa yang sedang berduka menunjukkan bahwa kesepian berhubungan dengan tingkat gejala depresi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesepian tidak hanya menjadi respons emosional terhadap kehilangan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis, memperpanjang durasi berduka, dan meningkatkan risiko gangguan mental jangka panjang pada individu yang berduka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesepian bukan hanya merupakan respons emosional terhadap kehilangan, tetapi juga faktor penting yang memengaruhi kesehatan mental jangka panjang mereka yang berduka.

2. Depresi

Kematian orang yang tercinta merupakan salah satu peristiwa hidup yang paling berisiko memicu depresi tanpa

memandang usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa depresi dapat terjadi bahkan setelah kematian yang diantisipasi. Dalam sebuah meta-analisis yang melibatkan individu lansia, berduka secara signifikan menjadi prediktor yang lebih kuat terjadinya depresi (OR = 3,3) terutama pada wanita (OR = 1,4), dan individu penyandang disabilitas (OR = 2,5).

Beberapa studi menemukan bahwa 20% janda dan duda yang baru saja kehilangan pasangan mengalami depresi. Angka ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh berduka terhadap kesehatan mental, bahkan pada individu yang mungkin sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Hal ini menyoroti pentingnya penanganan yang tepat untuk individu yang berduka, mengingat potensi dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan.

3. Resiko bunuh diri

Dalam jangka panjang, individu yang kesepian akibat berduka mengalami putus asa yang mendalam hingga memiliki pikiran bunuh diri. Perasaan kehilangan yang tak tertahankan dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan dapat menciptakan rasa kesendirian yang ekstrem, memperburuk perasaan tidak berguna, dan memperburuk pandangan pesimis terhadap masa depan.

Penelitian lainnya menunjukkan orang terdekat yang mengalami kehilangan akibat bunuh diri cenderung menunjukkan perasaan yang sama yaitu depresi dan ide bunuh diri. Mereka cenderung mengkritik dan menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa orang terkasih. Perasaan terperangkap dalam kenangan atau penyesalan, dikombinasikan dengan perubahan fisik dan emosional akibat stres yang berkepanjangan, dapat memperburuk risiko bunuh diri.

4. Penyalahgunaan Zat

Kesedihan yang tidak terselesaikan setelah kehilangan orang yang tercinta telah lama diakui sebagai pemicu gangguan penggunaan zat. Proses berduka yang mendalam sering kali memicu individu untuk mencari pelarian melalui penggunaan alkohol atau narkoba, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Sebaliknya, riwayat gangguan penggunaan zat juga menjadi faktor risiko utama untuk berkembangnya PGD setelah kehilangan. Ketergantungan pada zat tidak hanya dapat memperburuk proses berduka, tetapi juga membuat individu lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental lainnya yang sering menyertai berduka.

BAB 6

BUKTI ILMIAH TENTANG *GRIEF* DAN *BEREAVEMENT*

A. Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan dengan proses yang meliputi (a) merumuskan topik penelitian, (b) mencari studi yang relevan, (c) memilih studi, (d) memetakan data, dan (e) menyusun, merangkum, dan mengungkapkan temuan (Arksey & O'Malley, 2005). Pelaporan untuk *scoping review* mengikuti pedoman PRISMA (*preferred reporting items for systematic review and meta-analysis*) untuk *scoping review* (Tricco et al., 2018).

Pencarian literatur dilakukan di MedLine, Embase, CINAHL, Web of Science, Scopus, dan PubMed, tanpa pembatasan pada tanggal 25 April 2023, termasuk pencarian melalui Google Scholar, Portal Garuda, artikel relevan, dan daftar referensi untuk memastikan semua studi dapat ditemukan. Kata kunci, *subject heading*, dan operator Boolean digunakan untuk kata "duka" dan "Indonesia" (**Tabel 6.1**).

Table 6.1: Strategi Pencarian Literatur

Database	Syntax	Artikel
MedLine	Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to April 25, 2023> 1. Grief/ or Prolonged Grief Disorder/ or Disenfranchised Grief / 10113	16

	2. duka.mp.15 3. Indonesia.mp. or Indonesia/22273 4. 1 or 2 10128 5. 3 and 4 16	
Embase	('grief'/exp OR grief) AND indonesia:ti,ab,kw	10
CINAHL	(AB grief OR TX mourn OR TX mourning OR TX mourn OR TX mourning OR TX bereaved OR TX bereavement OR) AND AB Indonesia	6
Web of Science	Results for Grief OR Prolonged Grief Disorder OR Disenfranchised Grief OR sorrow OR sorrowed OR bereaved OR bereavement (All Fields) AND Indonesia (All Fields)	28
Scopus	(TITLE-ABS-KEY (indonesia)) AND ((TITLE-ABS-KEY (grief)) OR (TITLE-ABS-KEY (sorrow)) OR (TITLE-ABS-KEY (mourn OR mourning)) OR (TITLE-ABS-KEY (bereaved OR bereavement)))	75
PubMed	(grief[MeSH Terms]) AND (Indonesia)	20
Google Scholar	grief OR bereavement OR sorrow OR mourn OR duka OR berduka OR kabung OR berkabung AND Indonesia	

Data yang diambil dari literatur disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel, sesuai dengan lingkup dan tujuan dari *scoping review*. Proses ini dilakukan secara independen oleh setiap peninjau yang berpartisipasi pada tahap sebelumnya, dan peninjau ketiga mungkin dilibatkan untuk mencapai konsensus terhadap perbedaan yang ditemukan. Jawaban atas pertanyaan penelitian dalam artikel yang terpilih dirangkum, dan hasil numerik serta tematik

disajikan dalam format naratif dan tema, seperti yang ditunjukkan dalam hasil. Perangkat lunak QSR NVivo digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data.

Kriteria inklusi artikel yang dimasukkan dalam tinjauan ini adalah (1) desain studi empiris dalam bentuk apapun, baik kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran (*mixed methods*), (2) terkait dengan duka cita dan kehilangan, dan (3) penelitian dilakukan di Indonesia atau terkait dengan orang Indonesia. Artikel dikeluarkan berdasarkan kriteria: (1) topik tidak relevan, (2) data tidak memadai, (3) studi dalam bentuk tinjauan, abstrak, presentasi konferensi, atau protokol, dan (4) publikasi duplikat dari dataset yang sama.

Dua reviewer menyeleksi semua makalah menggunakan Rayyan.ai. Setelah menghapus duplikat, salah satu penulis meninjau judul dan abstrak artikel. Penulis pertama kemudian mengevaluasi kelayakan teks penuh berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pencarian manual terhadap meta-analisis yang telah dipublikasikan sebelumnya, artikel tinjauan, bibliografi, Portal Garuda, dan Google Scholar dilakukan untuk mengidentifikasi studi tambahan yang memenuhi syarat. Kami mengacu pada artikel dengan informasi paling rinci untuk investigasi yang berasal dari dataset yang sama. Penulis lain ikut serta dalam proses penyaringan untuk memastikan akurasi, dan diskusi tim digunakan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Setelah proses evaluasi, karakteristik studi yang disertakan dikumpulkan dan ditampilkan dalam tabel.

B. Hasil Penelusuran Literatur

Sebanyak 155 artikel ditemukan di enam database, dengan 61 artikel duplikat. Setelah menghapus kutipan duplikat, 94 makalah ditinjau oleh salah satu penulis berdasarkan judul dan abstrak. Setelah proses ini, 86 artikel dikeluarkan, dan 16 makalah ditinjau untuk kelayakannya. Sementara itu, pencarian manual melalui Google Scholar, Portal Garuda, artikel relevan, dan daftar referensi dilakukan untuk mengidentifikasi makalah potensial lainnya. Tiga studi terkait duka di Indonesia ditemukan; sayangnya, teks lengkapnya tidak dapat ditemukan dan dikeluarkan dari sintesis lebih lanjut. Namun, topik ketiga studi tersebut diidentifikasi berkaitan dengan pengembangan instrumen duka untuk perawat dan gaya koping wanita yang kehilangan pasangan akibat AIDS. Pada akhirnya, 18 artikel dimasukkan dalam analisis.

Studi pertama tentang duka di Indonesia diterbitkan pada tahun 2008, dan publikasi terbaru pada tahun 2023. Dari 18 studi, 55% dilakukan dengan desain kuantitatif menggunakan metode observasional, termasuk *cross-sectional* dan properti psikometrik. Sisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagian besar studi berlokasi di Jawa, terutama di Jakarta. Total partisipan adalah 2.814, dengan jumlah antara satu hingga 729 individu per studi. Mengenai populasi target, kelompok yang paling sering diteliti adalah orang yang hidup dengan HIV/AIDS, ibu yang kehilangan anak, pasangan yang berduka, lansia, dan pengasuh pasien dengan penyakit mengancam jiwa. **Tabel 6** menyajikan karakteristik studi yang termasuk dalam *scoping review*.

Tabel 6.2: Karakteristik Penelitian Perawatan Kedukaan di Indonesia

No.	Peneliti	Tujuan	Lokasi, desain, & partisipan penelitian	Hasil
1	Betrianan dan Kongsuwan (2020)	Untuk mendeskripsikan reaksi duka dan strategi coping perawat Muslim dalam menghadapi kematian pasien.	Indonesia <i>Fenomenologi kualitatif</i> Perawat muslim ICU (n=14).	Empat reaksi terhadap duka, empat faktor yang mempengaruhi reaksi terhadap duka, dan tiga strategi coping yang digunakan dalam menghadapi kematian di ICU.
2	Betrianan dan Kongsuwan (2019)	Untuk menjelaskan betapa pentingnya proses kedukaan yang dialami oleh perawat Muslim yang merawat pasien di unit perawatan intensif.	Sumatera Barat <i>Fenomenologi kualitatif</i> Perawat muslim ICU (n=14).	Lima kategori tematik utama yang mencerminkan lima dunia kehidupan diidentifikasi: 'pemahaman empatik', 'menyeimbangkan diri', 'penghindaran', 'memprediksi

				masa depan kematian diri sendiri', dan 'mengaitkan teknologi dalam tawar-menawar'.
3	Damar (2008)	Untuk menentukan kebutuhan akan program konseling duka cita khusus bagi perempuan yang terkena dampak HIV/AIDS yang kehilangan suami mereka karena AIDS serta layanan-layanan apa saja yang diperlukan.	Jakarta Kualitatif Wanita yang kehilangan pasangannya (n=6).	Empat tema utama: ketidaksadaran akan HIV/AIDS; menerima kenyataan sebagai janda dan hidup dengan HIV; peran "baru" sebagai orang tua tunggal, yaitu menjadi ibu bagi janda dari pasangan yang meninggal karena AIDS; dan pentingnya konseling yang menangani seropositifitas.

4	Djelantik dkk. (2021)	Untuk menentukan prevalensi, kelas laten, dan korelasi budaya dari gangguan duka berkepanjangan, PTSD, dan depresi pada anggota keluarga Bali setelah kecelakaan lalu lintas.	Bali Potongan melintang Keluarga yang suram karena kecelakaan lalu-lintas (n=301).	Budaya Bali mungkin melindungi para janda dari penyakit mental dan dapat menjadi referensi bagi ritus duka cita di negara lain.
5	Fauziah dan Kahija (2017)	Untuk memahami keadaan mental anak-anak yang kehilangan ibu karena bunuh diri.	Semarang Fenomenologi kualitatif Anak yang kehilangan ibunya karena bunuh diri (n=1).	Tema yang dikembangkan: (1) membahas ikatan ibu-anak. (2) Empat tema superordinat: syok emosional, perilaku menutup diri, kondisi psikologis, dan hubungan sosial. (3) Meliputi tiga tema superordinat: alasan

				pendukung pemulihan, perubahan positif setelah pemulihan, dan signifikansi pribadi dari pengalaman bunuh diri.
6	Indah (2021)	Untuk menyelidiki bagaimana dokter dan pasien yang berduka berinteraksi di Aceh pascabencana di Indonesia.	Aceh, Indonesia Fenomenologi kualitatif Pasien yang terkena bencana (n=11).	Terdapat hubungan kekuasaan asimetris yang berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional mereka.
7	Mariyana dan Betriana (2021)	Untuk menggambarkan pengalaman orang tua dan pengasuh yang merawat anak-anak dengan penyakit kronis.	Sumatera Barat Fenomenologi kualitatif Orang tua dan pengasuh anak dengan penyakit kronis (n=11).	Hasilnya mengungkapkan tiga kategori, yaitu ekspresi kepedulian, upaya kepedulian, dan cara menerima situasi.
8	Mas'amah dkk. (2023)	Untuk meningkatkan	Kupang Kualitatif	Analisis tematik

		layanan pemakaman bagi masyarakat adat dalam keadaan darurat atau krisis dan memberikan dukungan sosial bagi anggota keluarga yang berduka dan pekerja kamar mayat yang melakukan pemakaman selama pandemi COVID-19.	Keluarga yang berduka dan pekerja kamar jenazah (n=22).	mengungkapkan tiga tema: COVID-19 dan protokol pemakaman, kesulitan dalam melaksanakan ritual pemakaman budaya dan agama, dan rasa malu terhadap keluarga yang berduka.
9	Mujahidah dkk. (2015)	Untuk mempelajari kehilangan dan kedukaan di kalangan ibu yang kehilangan bayi.	Depok Fenomenologi kualitatif Ibu-ibu yang berduka karena kematian bayi (n=10).	Temanya adalah penyebab kematian bayi, tahap kedukaan, Respons Setelah Kehilangan, jaringan dukungan sosial, harapan pascakehilangan,

				kebijaksanaan kehilangan, dan mekanisme penanganan.
10	Mujahidah dan Suwarningsih (2021)	Untuk mengeksplorasi bagaimana dukungan sosial memengaruhi kehilangan dan kedudukan pada korban banjir dan tanah longsor.	Bogor <i>Cross-sectional</i> Korban banjir dan tanah longsor (n=150).	Bantuan sosial memengaruhi kedudukan dan kehilangan korban banjir dan tanah longsor.
11	Nugraha dkk. (2023)	Untuk mengevaluasi kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL) dan kesehatan mental pada 729 mahasiswa kedokteran Indonesia selama pandemi COVID-19	Indonesia <i>Cross-sectional</i> Mahasiswa kedokteran Indonesia (n=729).	37,3% memiliki komponen fisik yang terganggu, dan 66,9% memiliki komponen mental yang terganggu dari HRQoL.
12	Priastana dkk. (2018)	Untuk menyelidiki dukungan sosial keluarga dan ketahanan	Bali Potongan melintang Pria atau wanita	Dukungan sosial dan ketahanan keluarga

		orang lanjut usia yang menderita keduakaan kronis karena kehilangan pasangan dalam budaya Pakurenan dan hubungan di antara keduanya.	berusia 60 tahun atau lebih kehilangan pasangannya dalam waktu kurang dari 48 bulan (n=255).	berkorelasi positif.
13	Geni dan Rahmania (2013)	Untuk menentukan apakah mekanisme penanggulang an dan keduakaan antisipatif berhubungan di antara orang tua anak penderita kanker.	Jakarta Korelasi kuantitatif Orang tua dengan anak yang telah didiagnosis mengalami kanker (n=55).	Hasilnya menunjukkan bahwa keduakaan yang diantisipasi dan penanganan yang berfokus pada emosi keduanya berkorelasi positif, sedangkan penanganan yang berfokus pada agama tidak berkorelasi secara signifikan

				satu sama lain.
14	Rahmawati dkk. (2021)	Untuk mengidentifikasi variabel dimensi masyarakat yang terkait dengan kedukaan dan kehilangan selama pandemi COVID-19.	Indonesia Korelasi kuantitatif Orang Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas (n=278).	Dimensi sosial dari pendidikan, usia, jenis, gender, dan pekerjaan tidak menunjukkan hubungan apa pun dengan kehilangan dan kedukaan. Namun, usia dan pendidikan memiliki hubungan yang cukup dengan kehilangan dan kedukaan.
15	Ristriyani dkk. (2018)	Untuk mengidentifikasi penerimaan perempuan yang hidup dengan HIV dalam	Jakarta Penampang melintang Perempuan dengan HIV positif (n=235).	Para wanita semakin dekat untuk menerima sepenuhnya status HIV mereka.

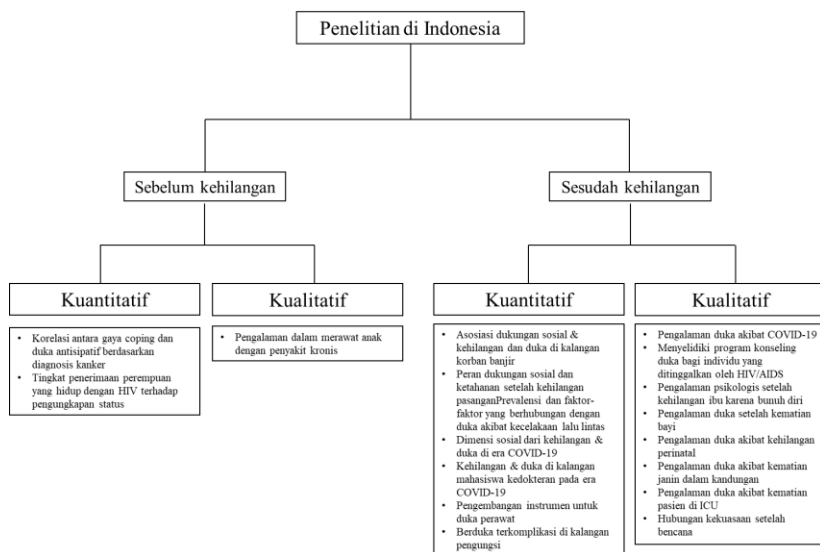
		kaitannya dengan pengungkapan status.		
16	Samutri dkk. (2022)	Untuk menyelidiki bagaimana kedukaan yang terus-menerus mempengaruhi wanita Indonesia yang mengalami kehilangan prenatal.	Yogyakarta Fenomenologi kualitatif Wanita yang mengalami kedukaan kronis akibat kehilangan perinatal dalam 7 minggu–3 tahun terakhir (n=9).	Tiga tema utama: (1) Kedukaan yang berulang merupakan hal yang umum, khususnya ketika dihadapkan pada pemicu tertentu (ingatan dan kenangan kehamilan); (2) mekanisme penanganan dan bantuan emosional yang tepat diperlukan untuk mengatasi kedukaan; (3) Aspek tertentu dari kedukaan kronis, seperti berkurangnya

				a kedukaan dan kehadiran anak lain yang bertindak sebagai pelipur lara dan sumber kedukaan, terkait dengan kehilangan perinatal.
17	Sinaga dkk. (2020)	Untuk mendeskripsikan pengalaman ibu dengan kematian janin dalam kandungan (IUFD) di Indonesia.	Lampung Fenomenologi kualitatif Ibu yang pernah mengalami kematian janin dalam kandungan (IUFD) (n=7).	Empat tema utama, meliputi reaksi ibu terhadap kehilangan, dukungan moral yang diterima ibu, perilaku tidak menyenangkan dari orang lain, serta perubahan fisik dan psikologis.
18	Tay dan kawan-kawan (2016)	Untuk menentukan apakah pengungsi Papua Barat memiliki	Warga Indonesia di Papua Nugini (n=230).	Konflik dan kehilangan yang dikaitkan dengan perasaan

		konstruksi kesatuan kedukaan yang rumit dan jika demikian, apakah struktur faktorialnya adalah struktur enam faktor atau salah satu PCBD atau PGD berdasarkan formulasi DSM-5 atau ICD-11.		ketidakadilan mungkin sangat bersifat patogen dalam menimbulkan komponen kemarahan/penilaian negatif dari kedukaan yang rumit di kalangan pengungsi.
--	--	--	--	--

Scoping review ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi (80%) berfokus pada duka setelah kehilangan **(Gambar 1)**. Tidak ada studi intervensi yang diidentifikasi, tetapi (Damar & du Plessis, 2010) menyelidiki kelayakan konseling duka menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk instrumen duka, *Inventory of Complicated Grief (ICG)*, *Inventory of Complicated Grief – Revised (ICG-R)*, *Prolonged Grief Disorder – 13* dan versi revisinya (PG-13 dan PG-13-R), serta *Brief Grief Questionnaire (BGQ)* adalah alat yang terverifikasi untuk diagnosis duka (Kustanti, Chu, et al., 2021). Namun, tidak ada dari instrumen ini yang digunakan oleh peneliti di Indonesia. Mereka menggunakan instrumen skrining duka, seperti *Acceptance of Disease and Impairments Questionnaire*, untuk mengukur gejala atau skala duka. Kelompok yang paling sering diperiksa adalah pengasuh pasien penyakit kronis seperti kanker dan HIV/AIDS. Populasi lain mencakup kematian terkait COVID-19 dan kematian mendadak akibat kehilangan pralahir,

kecelakaan, bunuh diri, dan bencana alam. Peneliti Indonesia juga tertarik mempelajari duka di kalangan perawat, mahasiswa kedokteran, pekerja pemakaman, pengunjung, dan masyarakat umum.



Gambar 6.3: Pola studi di Indonesia

Berdasarkan jenis duka dan kehilangan, studi di Indonesia dapat dibagi menjadi studi tentang duka antisipatif dan duka pasca-kehilangan. Di antara penelitian yang disertakan, tiga penelitian difokuskan pada area pra-kehilangan, yaitu kedukaan antisipatif. Dua penelitian menyelidiki mekanisme penanganan yang terkait dengan tahap penerimaan akibat kehilangan. Penelitian lain adalah tentang pengalaman merawat orang yang hidup dengan penyakit kronis dan tentang penerimaan terhadap diagnosis penyakit yang mengancam jiwa. Penelitian tentang kedukaan antisipatif sebagian besar berpusat pada pemeriksaan mekanisme penanganan, seperti tingkat penerimaan

pengasuh, dalam menanggapi penurunan kesehatan dan kematian yang akan datang.

Melakukan penelitian tentang pengalaman kehilangan dan kedukaan merupakan topik yang paling banyak dipelajari dalam kedukaan pascakehilangan. Dalam hal jenis kehilangan, kedukaan terkait penyakit kronis menjadi perhatian lebih besar bagi para peneliti daripada kehilangan mendadak. Untuk kehilangan yang tak terduga, populasi sarasannya adalah kecelakaan, bunuh diri, dan bencana. Mengingat pandemi juga dapat dianggap sebagai bencana, tiga investigasi tentang kedukaan terkait COVID-19 telah dilakukan. Beberapa penelitian tidak dapat dikategorikan apakah penelitian tersebut termasuk kematian yang diharapkan atau tidak diharapkan, seperti kematian orang di unit perawatan intensif atau kehilangan pasangan.

BAB 7

PELUANG PENELITIAN *GRIEF* DAN *BEREAVEMENT*

Tahun 1992 menandai dimulainya gerakan perawatan paliatif di Indonesia (Putranto et al., 2017). Dari hasil penelusuran literatur, studi perawatan duka pertama kali diterbitkan pada tahun 2008, sekitar enam belas tahun setelah gerakan perawatan paliatif pertama di Indonesia. Penelusuran literatur perlu dilakukan untuk mengidentifikasi status studi duka dan kedukaan di Indonesia dan untuk merekomendasikan bukti tambahan bagi gerakan *bereavement care* di Indonesia. Hasil penelusuran literatur telah mengidentifikasi topik-topik penelitian yang dilakukan di Indonesia, termasuk tujuan penelitian, penyebab kedukaan, populasi sasaran, konsep dan hasil yang dipelajari.

Mayoritas penelitian yang termasuk dalam tinjauan cakupan ini dilakukan di wilayah Jawa, dengan fokus khusus pada kota Jakarta. Meskipun ada kebijakan tentang perawatan paliatif di Indonesia sejak 2007, penerapannya terbatas pada lima kota besar: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Karena layanan perawatan paliatif terpusat di lima kota besar, khususnya di Jawa, tidak mengherankan bahwa penelitian tentang kedukaan juga sebagian besar difokuskan di wilayah ini. Oleh karena itu, masih ada peluang yang signifikan untuk menyelidiki praktik kedukaan dan berkabung di luar wilayah Jawa.

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa bidang kedukaan sebelum kehilangan mengandung sejumlah besar hal

yang belum dipetakan, yang tidak mengejutkan mengingat sedikitnya jumlah penelitian yang telah dilakukan pada subjek tersebut. Teknik mengatasi dalam menanggapi kehilangan yang akan terjadi sebagai akibat dari diagnosis penyakit yang mengancam jiwa adalah fokus utama bidang kedukaan antisipatif sebagai suatu topik. Faktanya, duka sebelum kehilangan bisa mempengaruhi mekanisme koping seseorang, dan tanpa pengobatan yang tepat, komplikasi bisa terjadi dan meningkatkan risiko gangguan kedukaan (Christina Yeni Kustanti et al., 2022). Seringkali, perubahan kognitif, perilaku, dan kepribadian yang dramatis menghilangkan hubungan penting yang mereka miliki dengan pasien sebelum timbulnya penyakit atau cedera (Yehene et al., 2021). Kecemasan, mati rasa secara emosional, dan kesulitan tidur lebih umum terjadi pada orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian orang yang dicintainya (Shear, 2012). Sebagian besar literatur akademis terkini tentang kedukaan sebelum kehilangan berfokus pada kedukaan akibat HIV, AIDS, dan kanker, selain berbagai penyakit kronis. Mungkin fokus perawatan tetap pada penanganan pasien. Namun, pengasuh atau anggota keluarga dari individu dengan penyakit kronis mungkin terus mengalami beban perawatan setelah kematian pasien. Oleh karena itu, memberikan bantuan bagi mereka yang sedang berduka sangat penting bagi kelompok demografi ini untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih serius. Karena pasien telah didiagnosis dengan penyakit yang mengancam jiwa, petugas kesehatan, termasuk perawat, dapat melakukan penilaian terhadap anggota keluarga atau pengasuh pasien untuk menentukan sejauh mana mereka mengalami kedukaan yang bersifat antisipasi. Pasien dan anggota keluarga mereka harus berpartisipasi dalam penilaian risiko duka cita menggunakan instrumen formal (Aoun et al., 2017). Oleh karena

itu, dukungan duka cita yang tepat dapat diatur terlebih dahulu (Kustanti, Fang, et al., 2021).

Penyebab kedukaan, seperti penyakit kronis dan kematian dini, diberi pertimbangan yang sama dalam hal duka paska-kehilangan. Setiap individu dan jenis kehilangan yang berbeda akan mengalami reaksi kedukaan yang berbeda pula (Zisook & Shear, 2009). Ketika membahas jenis-jenis kedukaan, para peneliti lebih memperhatikan kedukaan yang terkait dengan penyakit kronis. Penyakit kronis dapat menyebabkan keterbatasan fungsional, stres finansial, isolasi sosial, meningkatnya ketergantungan pada orang lain, rendahnya harga diri, dan masalah kesehatan mental yang mengganggu pengasuh bahkan setelah kematian pasien (Richman, 2022). Bahkan jika kematian akibat penyakit kronis diperkirakan terjadi, pengasuh mungkin tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengatasi situasi tersebut karena mereka memiliki begitu banyak tanggung jawab untuk merawat pasien. Akibatnya, hubungan yang terjalin antara penyedia layanan kesehatan dan keluarga pasien harus dipertahankan untuk tujuan pemberian perawatan duka cita. Perawatan duka cita harus dimulai dengan memantau kondisi kedukaan pasien setelah kematian pasien.

Di sisi lain, karena sifat dari kehilangan yang tidak terduga atau penyakit akut, suatu kehilangan bisa menjadi traumatis karena individu tersebut mungkin tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehilangan tersebut, yang bisa menjadi traumatis, termasuk selama masa pandemi COVID-19 (Neria & Litz, 2004). Korban kecelakaan, korban bunuh diri, dan korban bencana alam merupakan populasi sasaran untuk kehilangan tak terduga. Telah dilakukan tiga penelitian mengenai kedukaan terkait COVID-19, yang muncul sebagai akibat dari fakta bahwa pandemi juga dapat dianggap sebagai kematian tak terduga. Tindakan pencegahan keselamatan yang

bersifat andemis dapat memperburuk kehilangan dengan mengganggu proses berduka, menyebabkan dampak negatif pada kesehatan emosional dan fisik (Tao et al., 2022). Selain itu, kedukaan pasca kehilangan biasanya dialami di luar kantor medis dan fasilitas kesehatan, sehingga tidak banyak diketahui hingga menjadi masalah kesehatan. Keterlambatan pengakuan ini mungkin disebabkan oleh keadaan yang melatar-belakangi kematian mereka yang sangat traumatis, atau mungkin juga karena mereka sudah rentan (Parkes, 1998). Karena banyaknya penelitian yang telah dilakukan, kini kita dapat mengidentifikasi orang-orang yang berisiko lebih tinggi setelah mengalami kedukaan.

Populasi sasaran dan penyebab kedukaan bervariasi berdasarkan tema yang diambil dari bukti yang tersedia. Namun, tujuan penelitian terbatas pada prevalensi, pengalaman, pengembangan instrumen, eksplorasi peningkatan layanan, dan investigasi asosiasi, peluang untuk melakukan penelitian tentang kedukaan dan duka di Indonesia masih cukup terbuka. Penelitian intervensional, termasuk uji coba terkontrol acak, masih kurang. Faktanya, Indonesia memerlukan perawatan duka yang lebih peka terhadap budaya. Selain itu, konsep yang diteliti terbatas pada pengungkapan status HIV/AIDS, budaya, konseling duka, dukungan sosial, dan dimensi sosial. Hasil sosial dan psikologis lainnya, seperti kecemasan, juga akan menjadi perhatian di Indonesia. Studi tentang eksplorasi kedukaan di kalangan anak-anak juga penting untuk layanan perawatan duka yang lebih baik.

BAB 8

PENUTUP

Beberapa rekomendasi untuk penelitian terkait kedukaan di masa mendatang dapat dijelaskan. *Pertama*, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di bidang kedukaan antisipatif untuk memperkuat penanganan pengasuh atau anggota keluarga dari individu yang menderita penyakit yang mengancam jiwa guna mencegah kedukaan yang berkepanjangan atau rumit. *Kedua*, karena jenis kehilangan ini dapat lebih traumatis, penelitian tambahan tentang kedukaan terkait kematian yang tak terduga dapat dilakukan. *Ketiga*, belum ada penelitian yang dilakukan untuk memastikan kemanjuran intervensi duka cita. Saat ini sudah tersedia berbagai perawatan untuk orang yang berduka, tetapi penting untuk meneliti perawatan duka yang cocok untuk orang Indonesia. *Keempat*, orang yang berduka karena HIV, AIDS, dan kanker merupakan populasi yang paling sering diteliti. Ini memberikan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai jenis penyakit kronis, karena setiap kehilangan akan mengakibatkan kedukaan yang khas.

Kelima, studi terbatas telah dilakukan pada anak-anak dan remaja yang berduka. Oleh karena itu, rekan-rekan spesialis anak dapat mencurahkan lebih banyak perhatian pada topik ini. *Keenam*, desain studi yang lebih bervariasi dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih banyak penelitian tentang kedukaan dan duka, termasuk menggunakan *Randomized Controlled Trial* dengan variabel yang lebih multidimensi sebagai hasilnya. *Ketujuh*, terkait dengan penilaian gejala dan gangguan kedukaan, terdapat banyak instrumen yang

menunjukkan kemandirian yang patut dipuji. Meskipun demikian, para peneliti di Indonesia tidak menggunakan instrumen-instrumen ini. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah tidak tersedianya terjemahan instrumen di Indonesia. Lebih jauh, mayoritas penelitian yang termasuk dalam tinjauan cakupan ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian tambahan akan diperlukan untuk memfasilitasi penerjemahan dan validasi instrumen yang berkaitan dengan kedukaan ke dalam bahasa Indonesia. Ketersediaan instrumen akan meningkatkan akurasi dan efektivitas evaluasi gejala dan gangguan kedukaan baik dalam penelitian maupun praktik klinis.

Buku ini menjelaskan bahwa studi tentang kedukaan di Indonesia tidak memiliki variasi konsep yang sedang dipelajari; fokus harus diberikan pada perawatan paliatif, perawatan akhir hayat, dan perawatan duka untuk mendukung kemajuan perawatan paliatif di Indonesia. Selain merawat pasien yang sakit parah dan keluarga mereka, profesional perawatan kesehatan harus menawarkan dukungan emosional kepada mereka yang mengalami jenis kedukaan lainnya. Untuk penyediaan perawatan duka opsional, bukti tambahan akan diperlukan di bidang kedukaan antisipatif, kedukaan yang terkait dengan kematian yang tidak terduga, kemandirian intervensi duka, populasi lain dengan kondisi kronis, anak-anak, dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2021). *Nursing Diagnosis Handbook, Revised Reprint with 2021-2023 NANDA-I® Updates-E-Book*. Elsevier Health Sciences
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Aoun, S. M., Rumbold, B., Howting, D., Bolleter, A., & Breen, L. J. (2017). Bereavement support for family caregivers: The gap between guidelines and practice in palliative care. *PLoS ONE*, 12(10), e0184750. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184750>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Boelen, P. A., Lenferink, L. I., Nickerson, A., & Smid, G. E. (2018). Evaluation of the factor structure, prevalence, and validity of disturbed grief in DSM-5 and ICD-11. *Journal of Affective Disorders*, 240, 79-87. [10.1016/j.jad.2018.07.041](https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.041)
- Buckley, T., Sunari, D., Marshall, A., Bartrop, R., McKinley, S., & Tofler, G. (2012). Physiological correlates of bereavement and the impact of bereavement interventions. *Dialogues in clinical neuroscience*, 14(2), 129-139. [10.31887/DCNS.2012.14.2/tbuckley](https://doi.org/10.31887/DCNS.2012.14.2/tbuckley)
- Damar, A. P., & du Plessis, G. (2010). Coping versus grieving in a "death-accepting" society: AIDS-bereaved women living with HIV in Indonesia. *J Asian Afr Stud*, 45(4), 424-431. <https://doi.org/10.1177/0021909610373904>

- Djelantik, A., Smid, G. E., Mroz, A., Kleber, R. J., & Boelen, P. A. (2020). The prevalence of prolonged grief disorder in bereaved individuals following unnatural losses: Systematic review and meta regression analysis. *J Affect Disord*, 265, 146-156. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.034>
- Eckholdt, L., Watson, L., & O'Connor, M. (2018). Prolonged grief reactions after old age spousal loss and centrality of the loss in post loss identity. *Journal of Affective Disorders*, 227, 338-344. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.010>
- Eisma, M. C., Rosner, R., & Comtesse, H. (2020). ICD-11 prolonged grief disorder criteria: turning challenges into opportunities with multiverse analyses. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 752. [10.3389/fpsy.2020.00752](https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00752)
- Eisma, M. C., & Buyukcan-Tetik, A. (2024). Prolonged Grief Symptoms Predict Social and Emotional Loneliness and Depression Symptoms. *Behavior Therapy*. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2024.04.014>
- Guldin, M. B. (2014). Complicated grief - A challenge in bereavement support in palliative care: An update of the field [Article]. *Progress in Palliative Care*, 22(3), 136-142. <https://doi.org/10.1179/1743291X13Y.0000000078>
- Hao, F., Qiu, F., Liang, Z., & Li, P. (2024). Psychotherapies for prolonged grief disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis. *Asian Journal of Psychiatry*, 104133. [10.1016/j.ajp.2024.104133](https://doi.org/10.1016/j.ajp.2024.104133)
- Hopf, D., Eckstein, M., Aguilar-Raab, C., Warth, M., & Ditzen, B. (2020). Neuroendocrine mechanisms of grief and bereavement: A systematic review and implications for future interventions. *Journal of Neuroendocrinology*,

- 32(8), e12887.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1111/jne.12887>
- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Huang, T.-W., Jen, H.-J., Liu, D., Shen Hsiao, S.-T., & Chou, K.-R. (2022). Prevalence of grief disorders in bereaved families of cancer patients: A meta-analysis. *PALLIATIVE MEDICINE*, 36(2), 305-318.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1177/02692163211066747>
- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Liu, D., Pien, L.-C., Jen, H.-J., Shen, S.-T. H., Chen, J.-H., & Chou, K.-R. (2021). Evaluation of the performance of instruments to diagnose grief disorders: A diagnostic meta-analysis. *INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES*, 120, 103972.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103972>
- Kustanti, C. Y., Chu, H., Kang, X. L., Pien, L. C., Chen, R., Tsai, H. T., & Chou, K. R. (2022). Anticipatory grief prevalence among caregivers of persons with a life-threatening illness: A meta-analysis [Article in Press]. *BMJ SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE*.
<https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2021-003338>
- Kustanti, C. Y., Fang, H. F., Linda Kang, X., Chiou, J. F., Wu, S. C., Yunitri, N., Chu, H., & Chou, K. R. (2021). The Effectiveness of Bereavement Support for Adult Family Caregivers in Palliative Care: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP*, 53(2), 208-217. <https://doi.org/10.1111/jnu.12630>
- Kustanti, C. Y., Jen, H. J., Chu, H., Liu, D., Chen, R., Lin, H. C., Chang, C. Y., Pien, L. C., Chiang, K. J., & Chou, K. R. (2023). Prevalence of grief symptoms and disorders in the time of COVID-19 pandemic: A meta-analysis. *Int J Ment*

- Health Nurs*, 32(3), 904-916.
<https://doi.org/10.1111/inm.13136>
- Levi-Belz, Y., & Blank, C. (2023). The longitudinal contribution of prolonged grief to depression and suicide risk in the aftermath of suicide loss: The moderating role of self-criticism. *Journal of affective disorders*, 340, 658-666.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.08.023>
- Lundorff, M., Holmgren, H., Zachariae, R., Farver-Vestergaard, I., & O'Connor, M. (2017). Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*, 212, 138-149.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.01.030>
- Neria, Y., & Litz, B. T. (2004). BEREAVEMENT BY TRAUMATIC MEANS: THE COMPLEX SYNERGY OF TRAUMA AND GRIEF. *J Loss Trauma*, 9(1), 73-87.
<https://doi.org/10.1080/15325020490255322>
- Parkes, C. M. (1998). Bereavement in adult life. *Bmj*, 316(7134), 856-859. <https://doi.org/10.1136/bmj.316.7134.856>
- Pitman, A., Stevenson, F., King, M., & Osborn, D. (2020). Self-Reported Patterns of Use of Alcohol and Drugs After Suicide Bereavement and Other Sudden Losses: A Mixed Methods Study of 1,854 Young Bereaved Adults in the UK [Original Research]. *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, 11. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01024>
- Prigerson, H. G., Boelen, P. A., Xu, J., Smith, K. V., & Maciejewski, P. K. (2021). Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale. *World Psychiatry*, 20(1), 96-106.
<https://doi.org/10.1002/wps.20823>
- Prigerson, H. G., Frank, E., Kasl, S. V., Reynolds, C. F., 3rd, Anderson, B., Zubenko, G. S., Houck, P. R., George, C. J.,

- & Kupfer, D. J. (1995). Complicated grief and bereavement-related depression as distinct disorders: preliminary empirical validation in elderly bereaved spouses. *Am J Psychiatry*, 152(1), 22-30. <https://doi.org/10.1176/ajp.152.1.22>
- Putranto, R., Mudjaddid, E., Shatri, H., Adli, M., & Martina, D. (2017). Development and challenges of palliative care in Indonesia: role of psychosomatic medicine. *Biopsychosoc Med*, 11, 29. <https://doi.org/10.1186/s13030-017-0114-8>
- Richman, S. (2022). Grief and Chronic Disease.
- Rochmawati, E., Wiechula, R., & Cameron, K. (2016). Current status of palliative care services in Indonesia: a literature review. *Int Nurs Rev*, 63(2), 180-190. <https://doi.org/10.1111/inr.12236>
- Rosner, R., Comtesse, H., Vogel, A., & Doering, B. K. (2021). Prevalence of prolonged grief disorder. *Journal of affective disorders*, 287, 301-307.
- Sealey, M., Breen, L. J., O'Connor, M., & Aoun, S. M. (2015). A scoping review of bereavement risk assessment measures: Implications for palliative care. *Palliat Med*, 29(7), 577-589. <https://doi.org/10.1177/0269216315576262>
- Sekowski, M., & Prigerson, H. G. (2022). Associations between symptoms of prolonged grief disorder and depression and suicidal ideation. *British journal of clinical psychology*, 61(4), 1211-1218. [10.1111/bjc.12381](https://doi.org/10.1111/bjc.12381)
- Shear, M. K. (2012). Grief and mourning gone awry: pathway and course of complicated grief. *Dialogues Clin Neurosci*, 14(2), 119-128. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2012.14.2/mshear>

- Szuhany, K. L., Malgaroli, M., Miron, C. D., & Simon, N. M. (2021). Prolonged grief disorder: Course, diagnosis, assessment, and treatment. *Focus*, 19(2), 161-172. [10.1176/appi.focus.20200052](https://doi.org/10.1176/appi.focus.20200052)
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). *Standar diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tao, X., Yu, C. C., & Low, J. A. (2022). Exploring loss and grief during the COVID-19 pandemic: A scoping review of qualitative studies. *Ann Acad Med Singap*, 51(10), 619-628. <https://doi.org/10.47102/annals-acadmedsg.2021460>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., Lewin, S., Godfrey, C. M., Macdonald, M. T., Langlois, E. V., Soares-Weiser, K., Moriarty, J., Clifford, T., Tunçalp, Ö., & Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/m18-0850>
- Verderly, A. M., Smith-Greenaway, E., Margolis, R., & Daw, J. (2020). Tracking the reach of COVID-19 kin loss with a bereavement multiplier applied to the United States. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 117(30), 17695-17701. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007476117>
- WHO. (2020). *Palliative care*. Retrieved July 20, 2023 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- WHO. (2022). *14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021*. Retrieved

- December 16, 2022 from
<https://www.who.int/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-were-associated-with-the-covid-19-pandemic-in-2020-and-2021>
- WHO. (2021). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.).
<https://icd.who.int/>
- Yehene, E., Manevich, A., & Rubin, S. S. (2021). Caregivers' Grief in Acquired Non-death Interpersonal Loss (NoDIL): A Process Based Model With Implications for Theory, Research, and Intervention. *Front Psychol*, 12, 676536.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.676536>
- Zisook, S., & Shear, K. (2009). Grief and bereavement: what psychiatrists need to know. *World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 8(2), 67-74.
<https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2009.tb00217.x>
- Zisook, S., Iglewicz, A., Avanzino, J., Maglione, J., Glorioso, D., Zetumer, S., ... & Shear, M. K. (2014). Bereavement: course, consequences, and care. *Current psychiatry reports*, 16, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s11920-014-0482-8>
- Zisook, S., Shear, M. K., Reynolds, C. F., Simon, N. M., Mauro, C., Skritskaya, N. A., Lebowitz, B., Wang, Y., Tal, I., Glorioso, D., & et al. (2018). Treatment of Complicated Grief in Survivors of Suicide Loss: a HEAL Report [Journal Article; Clinical Trial Protocol]. *Journal of Clinical Psychiatry*, 79(2). <https://doi.org/10.4088/JCP.17m11592>

GLOSARIUM

B

Bonding: adalah keeratan hubungan.

C

Caregiver: adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu orang sakit.

CI: adalah *Confidence Interval*.

Complicated grief: adalah reaksi berduka yang terkomplikasi.

D

Database: adalah data yang tersimpan dan terindeks secara elektronik.

Diagnosa: adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan suatu kondisi penyakit.

DSM: adalah *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses*.

Duka: adalah respon normal atau wajar, yang dialami oleh keluarga.

F

Forest plot: adalah grafik untuk menunjukkan hasil gabungan analisis.

I

ICD: adalah *International Classification for Diseases and Related Health Problems*.

ICG: adalah *Inventory of Complicated Grief*.

Instrumen: adalah alat ukur untuk memperoleh data.

K

Kortisol: adalah hormon steroid yang berhubungan dengan stress.

Kronis: adalah penyakit menahun.

Kuratif: upaya pengobatan.

L

Life-threatening illness: adalah penyakit yang mengancam jiwa.

N

NANDA: adalah *North American Nursing Diagnosis Association*.

NIC: adalah *nursing intervention classification*.

P

Palliative care: adalah perawatan orang dengan penyakit yang mengancam jiwa.

PGD: adalah *Prolonged Grief Disorder*.

PG-13: adalah *Prolonged Grief Disorder – 13*

PRISMA: adalah *preferred reporting items for systematic review and meta-analysis*.

PTSD: adalah *post-traumatic stress disorder*

PTM: adalah Penyakit Tidak Menular.

PCBD: adalah *Persistent Complex Bereavement Disorder*.

Prolonged Grief Disorder: adalah reaksi berduka yang terkomplikasi.

S

Scoping review: adalah upaya untuk menganalisis publikasi penelitian topik tertentu.

SDKI: adalah Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia.

Strategi pencarian: adalah susunan kata kunci yang digunakan untuk pencarian literatur.

Subject heading: adalah kata utama yang digunakan untuk mengindeks kata kunci.

T

Kondisi terminal: adalah kondisi menjelang akhir kehidupan (ajal).

PROFIL PENULIS



Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D Lahir di Yogyakarta, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Bethesda Yakkum Yogyakarta pada 1999. S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Charles Darwin University dan Flinders University, Australia di tahun 2010 dan 2013. Study S3 diselesaikan pada 2023 di Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta sejak tahun 2003. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel, pengelola jurnal, narasumber seminar, serta *founder* untuk BerCa.my.id, sebuah *website* untuk dukungan *bereavement* secara virtual. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yeni@stikesbethesda.ac.id

PROFIL PENULIS



Ninik Yunitri, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J, Ph.D Lahir di Tanjung pinang, 24 September 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia tahun 2010. Study

S3 diselesaikan pada 2022 di Taipei Medical University, Taiwan.

Saat ini penulis

bekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2008. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel, pengelola jurnal, narasumber seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

yunitri@umj.ac.id

SINOPSIS BUKU

Perkembangan perawatan paliatif di Indonesia telah dimulai di tahun 1992, tetapi masih banyak masyarakat umum dan bahkan tenaga kesehatan yang belum mengetahui tentang perawatan paliatif. Paling tidak, area paliatif primer dan perawatan akhir kehidupan sudah banyak dipelajari, diteliti, dan dipahami. Area terakhir dari perawatan paliatif, yaitu *bereavement care*, masih memerlukan banyak sosialisasi dan penelitiannya di Indonesia.

Buku ini menyajikan konsep dasar dari *bereavement care* atau perawatan masa kedukaan, beserta peluang penelitiannya yang dapat dilakukan di Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan bahwa peneliti di bidang perawatan paliatif, khususnya di area *bereavement care*, mendapatkan gambaran tentang penelitian dan bahkan peluang pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan di masa mendatang.

Materi dalam buku ini dimulai dengan bagian pengantar tentang *bereavement care*, untuk memberikan informasi dasar tentang pengertian area perawatan paliatif ini. Selain itu juga disajikan kejadian kedukaan yang terkomplikasi, yang menjadi dasar mengapa peneliti perlu memberikan perhatian kepada area perawatan ini. Berbagai cara diagnosis dan skrining juga disajikan di dalam buku ini, dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai luaran dan alat ukur yang dapat digunakan di dalam penelitian yang berhubungan dengan duka dan kedukaan. Sampai di bagian akhir dari buku yang menyajikan berbagai projek penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, serta analisis peluang penelitian di masa berikutnya.

Perkembangan perawatan paliatif di Indonesia telah dimulai di tahun 1992, tetapi masih banyak masyarakat umum dan bahkan tenaga kesehatan yang belum mengetahui tentang perawatan paliatif. Paling tidak, area paliatif primer dan perawatan akhir kehidupan sudah banyak dipelajari, diteliti, dan dipahami. Area terakhir dari perawatan paliatif, yaitu bereavement care, masih memerlukan banyak sosialisasi dan penelitiannya di Indonesia.

Buku ini menyajikan konsep dasar dari bereavement care atau perawatan masa kedukaan, beserta peluang penelitiannya yang dapat dilakukan di Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan bahwa peneliti di bidang perawatan paliatif, khususnya di area bereavement care, mendapatkan gambaran tentang penelitian dan bahkan peluang pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan di masa mendatang.

Materi dalam buku ini dimulai dengan bagian pengantar tentang bereavement care, untuk memberikan informasi dasar tentang pengertian area perawatan paliatif ini. Selain itu juga disajikan kejadian kedukaan yang terkomplikasi, yang menjadi dasar mengapa peneliti perlu memberikan perhatian kepada area perawatan ini. Berbagai cara diagnosis dan skrining juga disajikan di dalam buku ini, dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai luaran dan alat ukur yang dapat digunakan di dalam penelitian yang berhubungan dengan duka dan kedukaan. Sampai di bagian akhir dari buku yang menyajikan berbagai proyek penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, serta analisis peluang penelitian di masa berikutnya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-01-6



9

786347

139016